

Répétitoire

Prof. Gian Dorta
Service de Gastro-entérologie et
d'Hépatologie CHUV

- **Un patient de 67 ans consulte après un voyage en Irlande pour une constipation apparue il y a 4 mois avec une selle formée tous les 4 jours. Il n'a pas remarqué de sang dans les selles, il n'y a pas de fièvre, de douleurs abdominales ou de comorbidités connues. Légère perte de poids de 2 kg. Se sent plus fatigué dans les derniers 3 semaines. Vous lui proposez en premier lieu:**

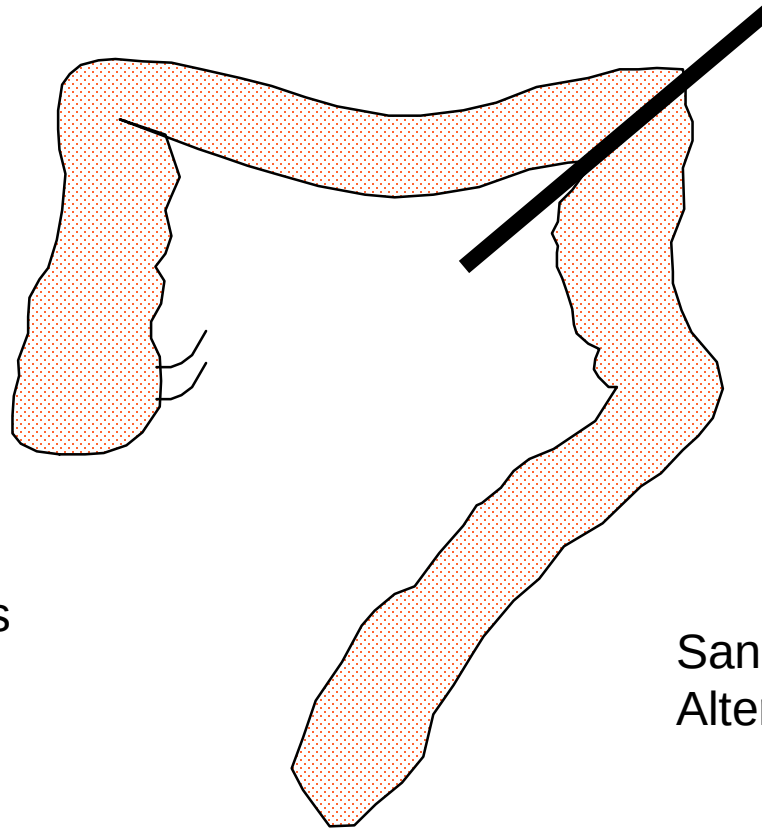
- A) Recherche de sang occulte dans les selles
- B) Dosage de la TSH
- C) Dosage du CEA
- D) Colonoscopie
- E) Traitement laxatif

- **Un patient de 67 ans consulte après un voyage en Irlande pour une constipation apparue il y a 4 mois avec une selle formée tous les 4 jours. Il n'a pas remarqué de sang dans les selles, il n'y a pas de fièvre, de douleurs abdominales ou de comorbidités connues. Légère perte de poids de 2 kg. Se sent plus fatigué dans les derniers 3 semaines. Vous lui proposez en premier lieu:**

- A) Recherche de sang occulte dans les selles
- B) Dosage de la TSH
- C) Dosage du CEA
- D) **Colonoscopie**
- E) Traitement laxatif

D

Symptômes d'alerte (précoces)

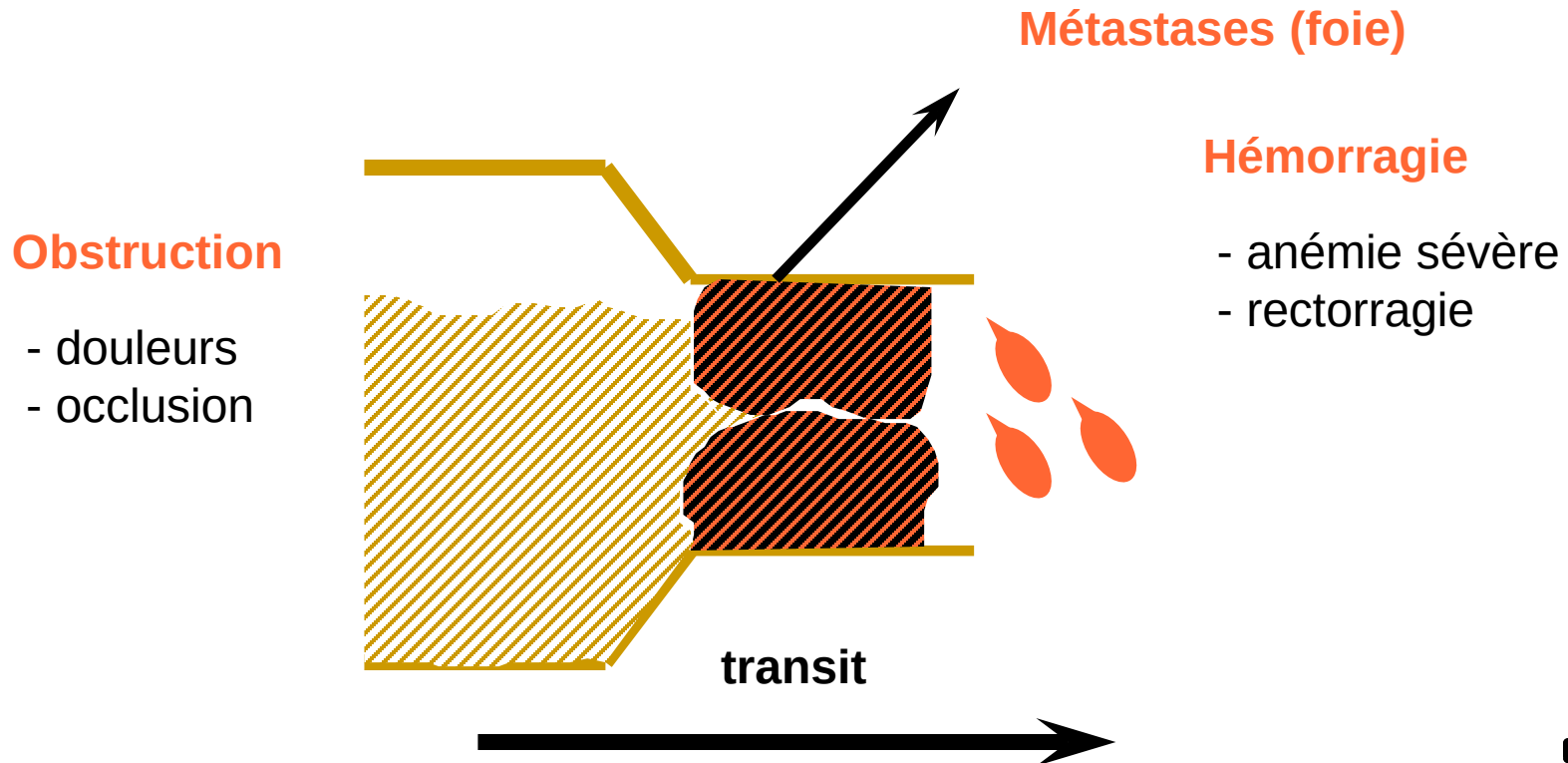


Anémie
Fatigue
Alternance des selles

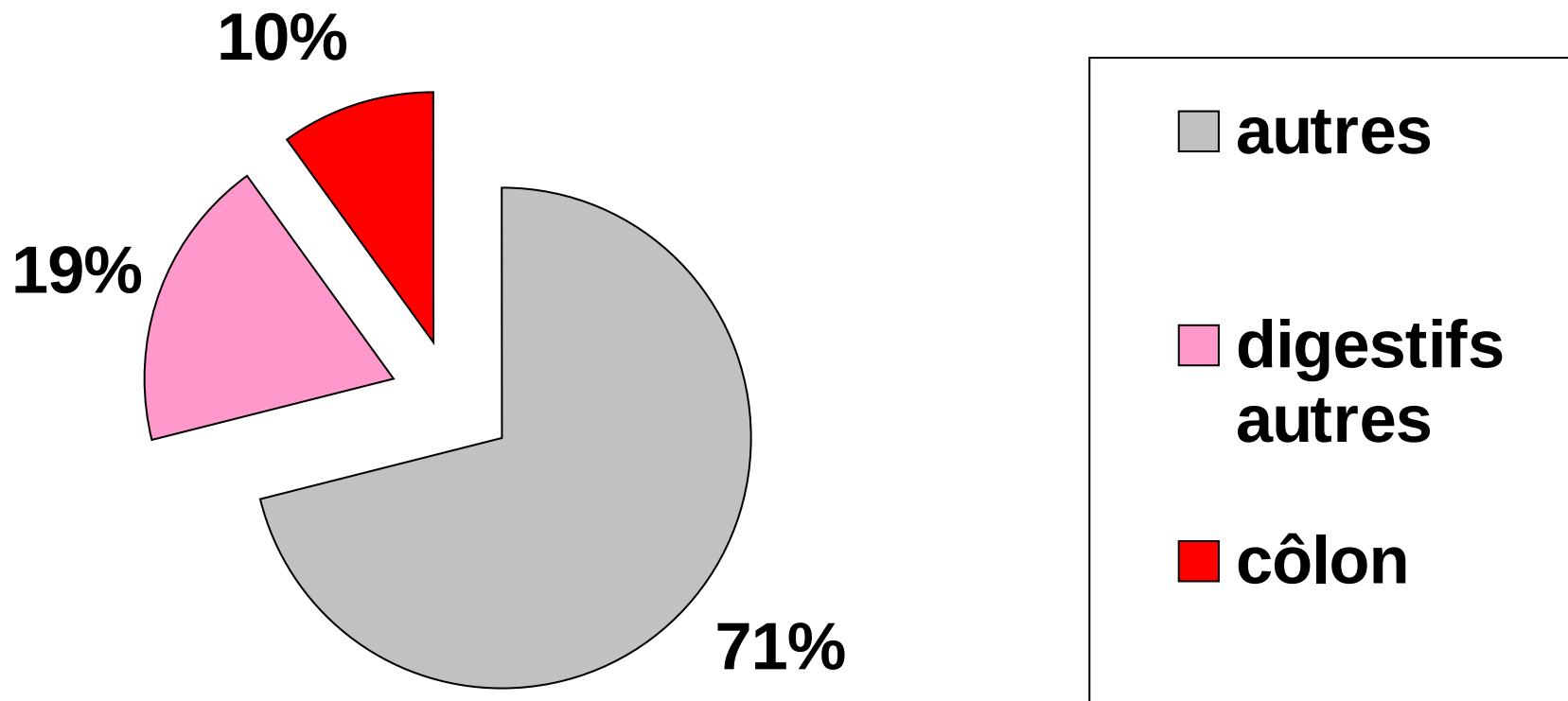
Sang dans les selles
Alternance des selles

Symptômes tardifs du cancer colorectal

Symptômes généraux: fatigue, perte de poids



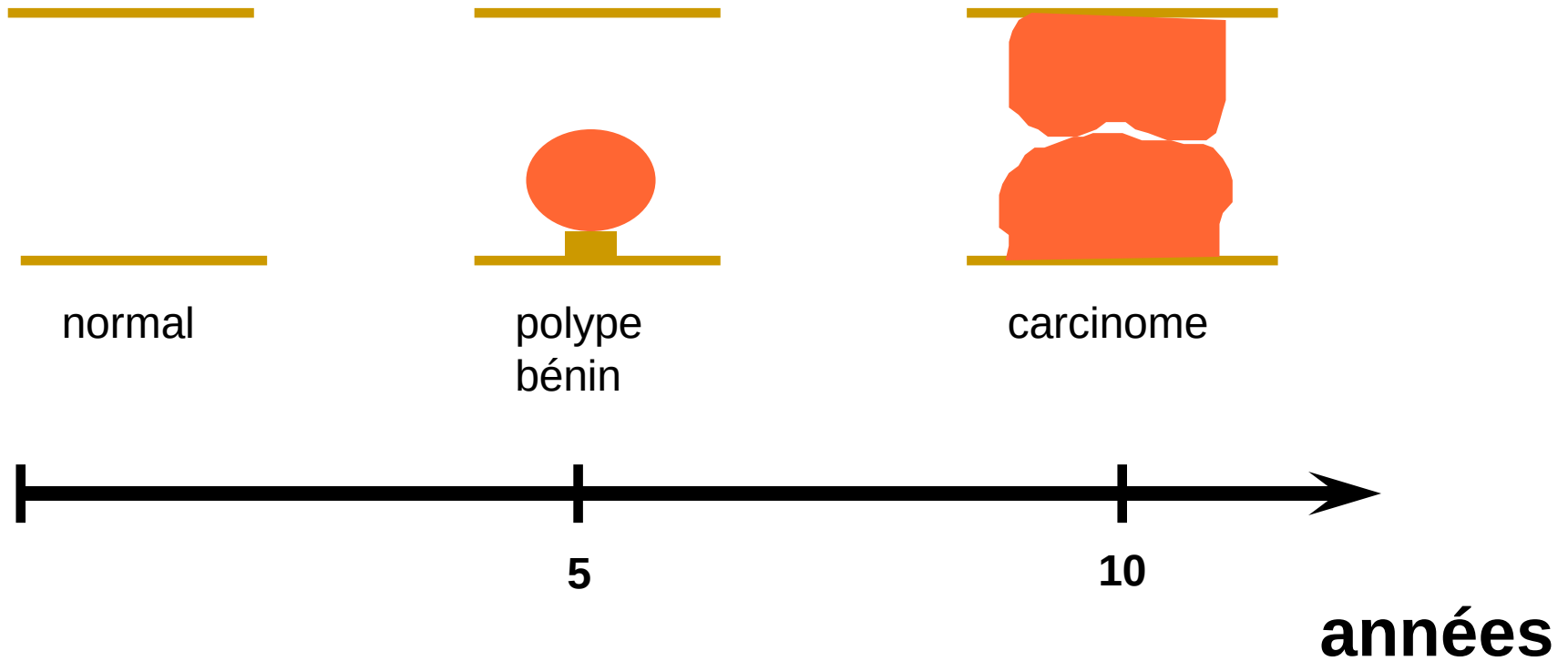
Les cancers digestifs en Suisse





5 %

Développement du carcinome colorectal sporadique



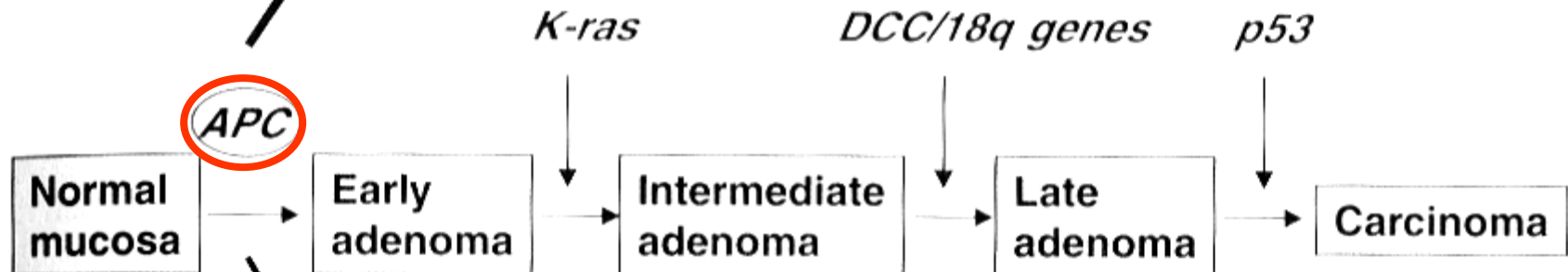
PATHWAYS OF COLON CARCINOGENESIS

FAP/sporadic

Chromosomal Instability

- Aneuploidy
- LOH
- Tumor suppressor gene mutations

85%



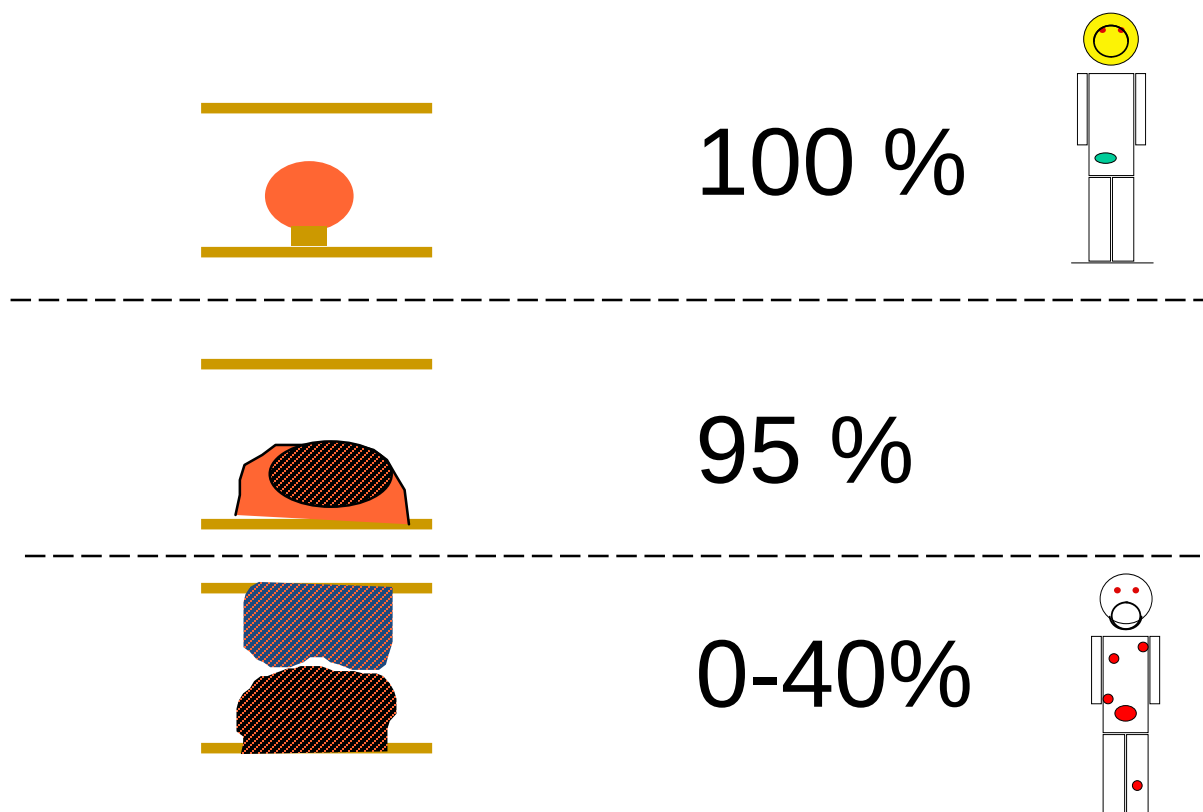
15%

HNPCC

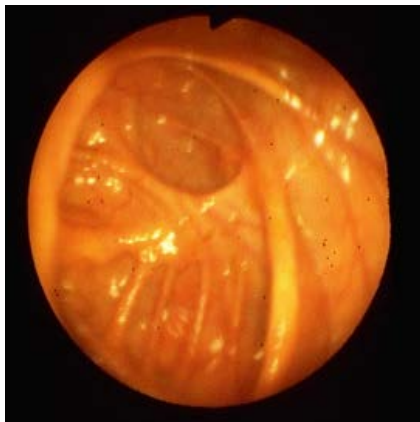
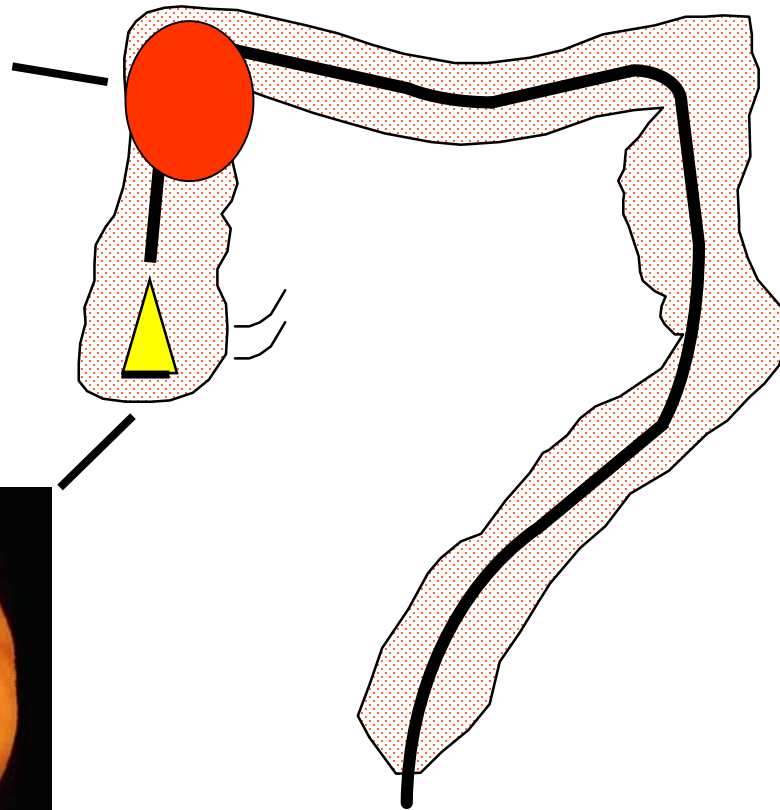
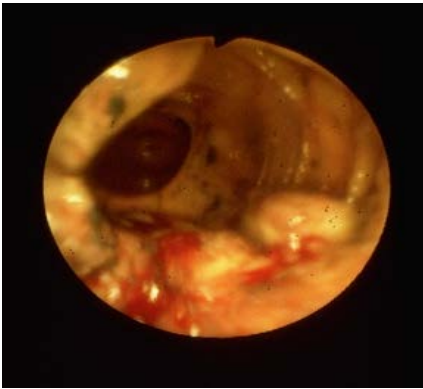
Microsatellite Instability

- Hypermethylation/mutation of DNA MMR genes
- Target gene alterations (TGF β RII; others)

Survie à 5 ans



Diagnostic: Colonoscopie

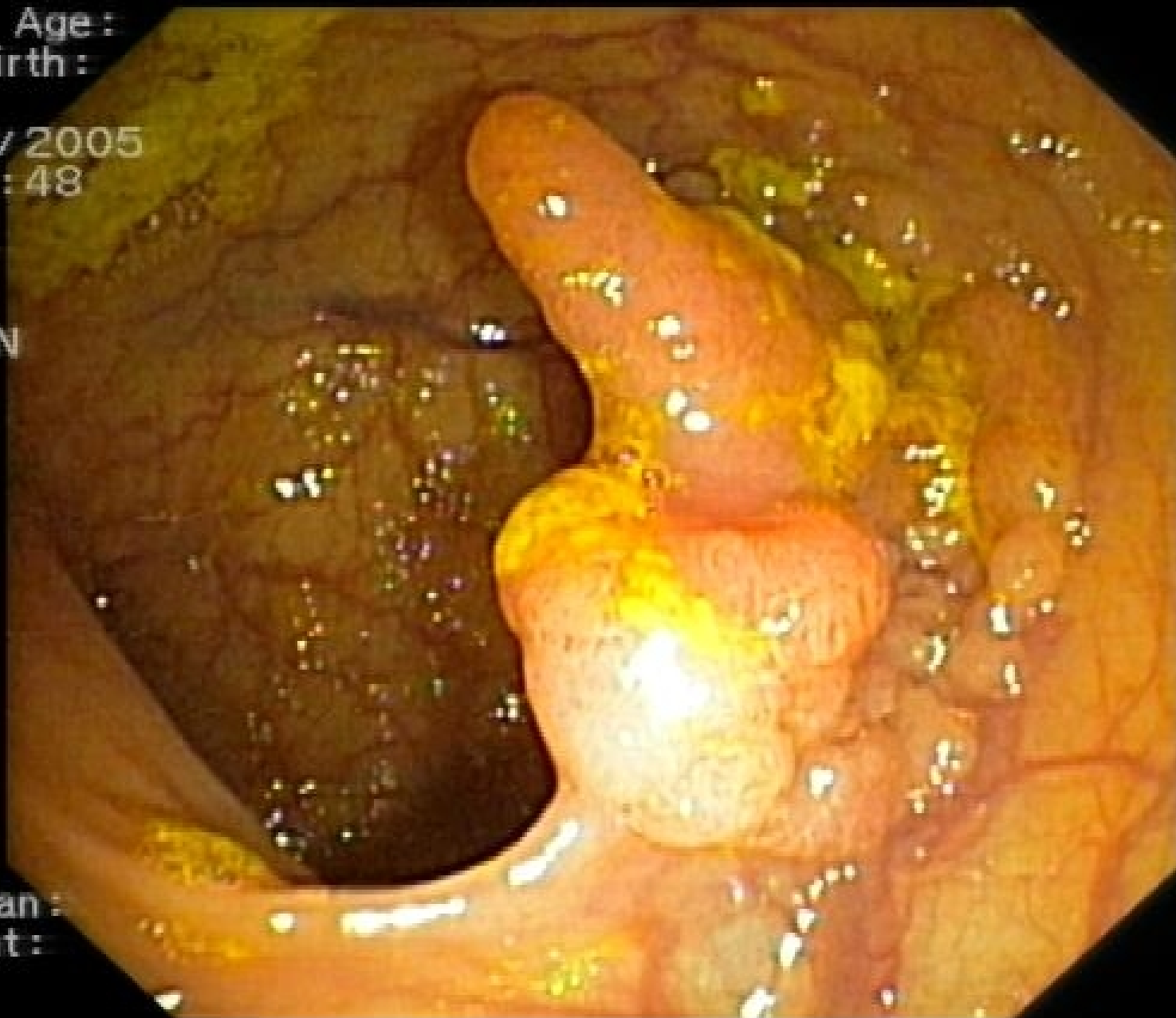


Archimi

F Age:
D. O. Birth:

22/04/2005
09:11:48

CVP: 7
D. F:
EH: 5 Cr: N



Physician:
Comment:

Caractéristiques de polypes

- **Adénome :** 20 % dégénérescence cancéreuse
prévalence : 15- 25 % / 50 –70 ans
- **Polype descriptif:** histologie !
- Histologie: Low grade dysplasia
High grade dysplasie
Cancer *in situ*

Polype

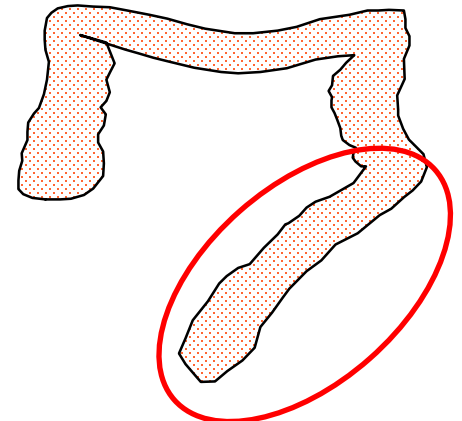
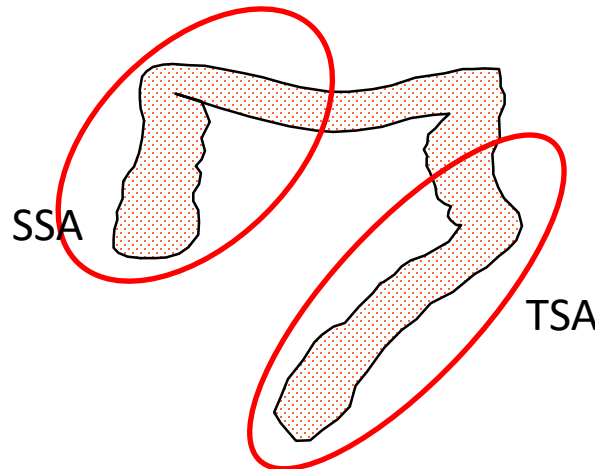
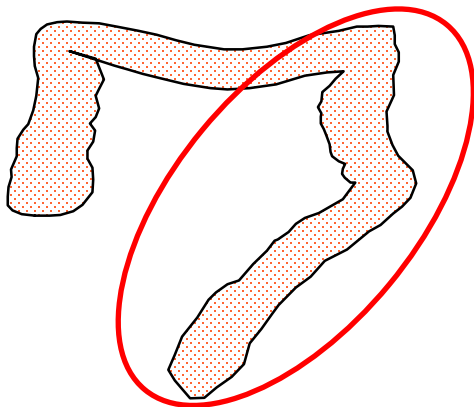
!!!

Polypes hyperplasiques

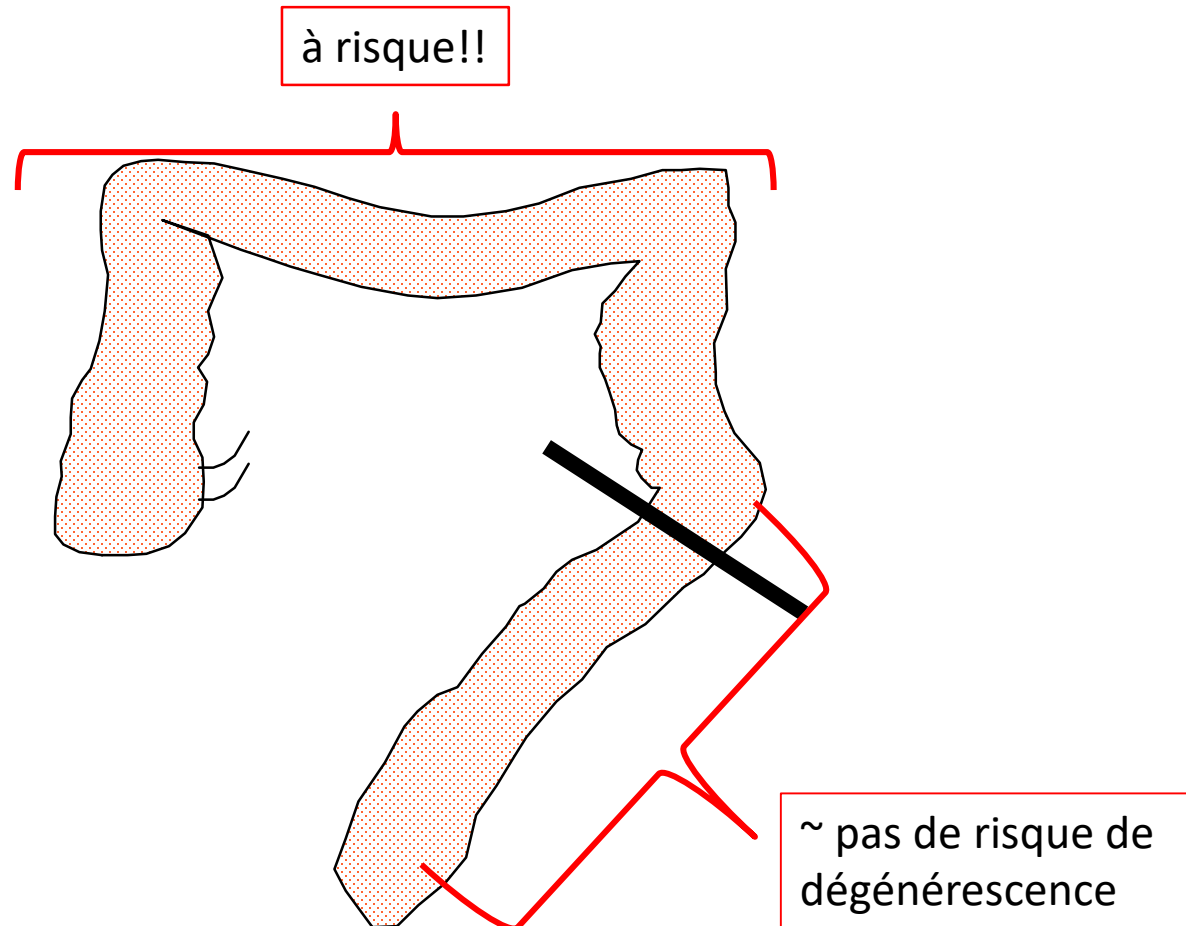
Adénome:
tubulaire
tubulo-villeux
villeux

Adénome dentelé:
serrated

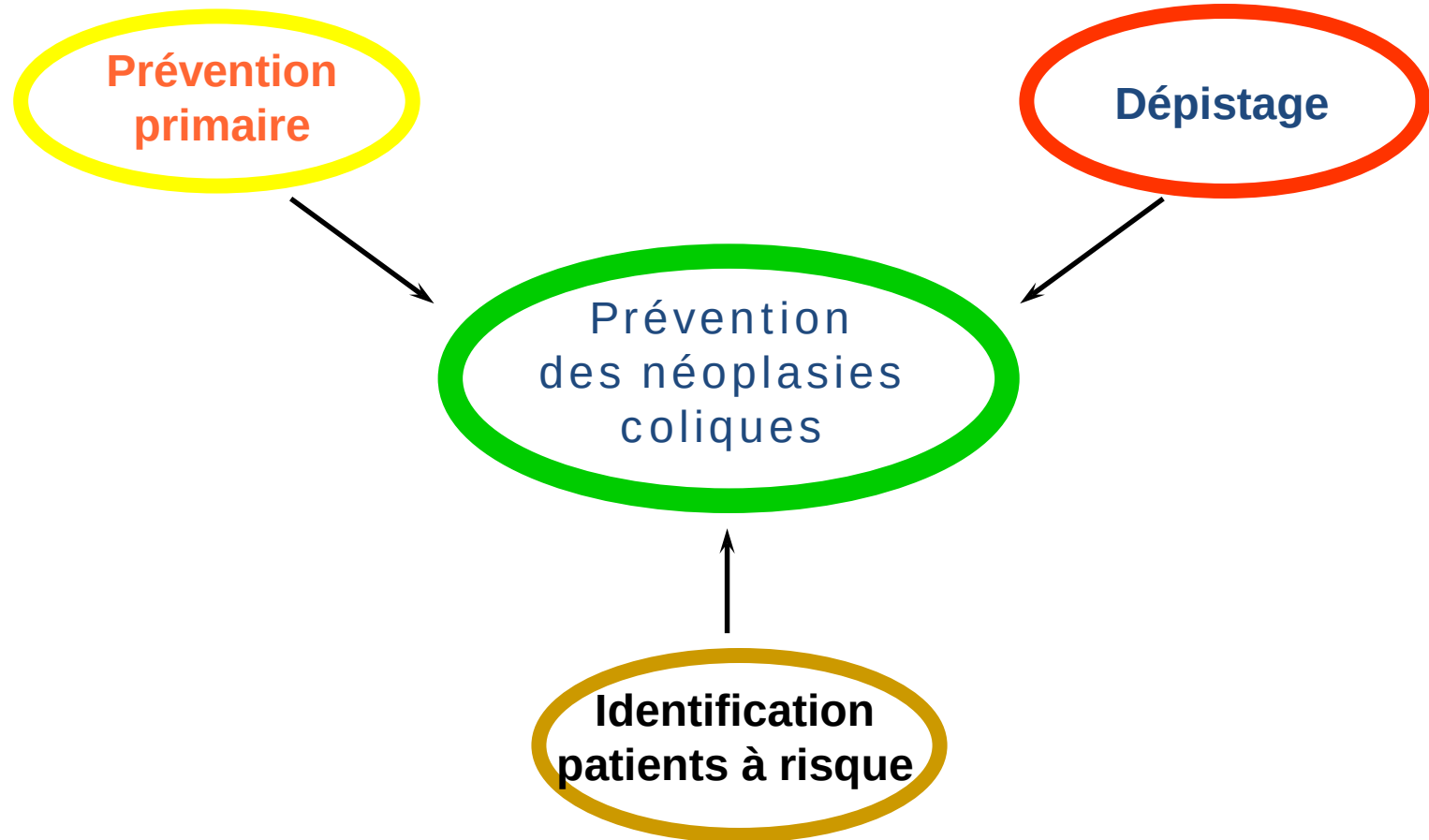
Polypes hyperplasiques:
sigmoïde/rectum



Polypes hyperplasiques

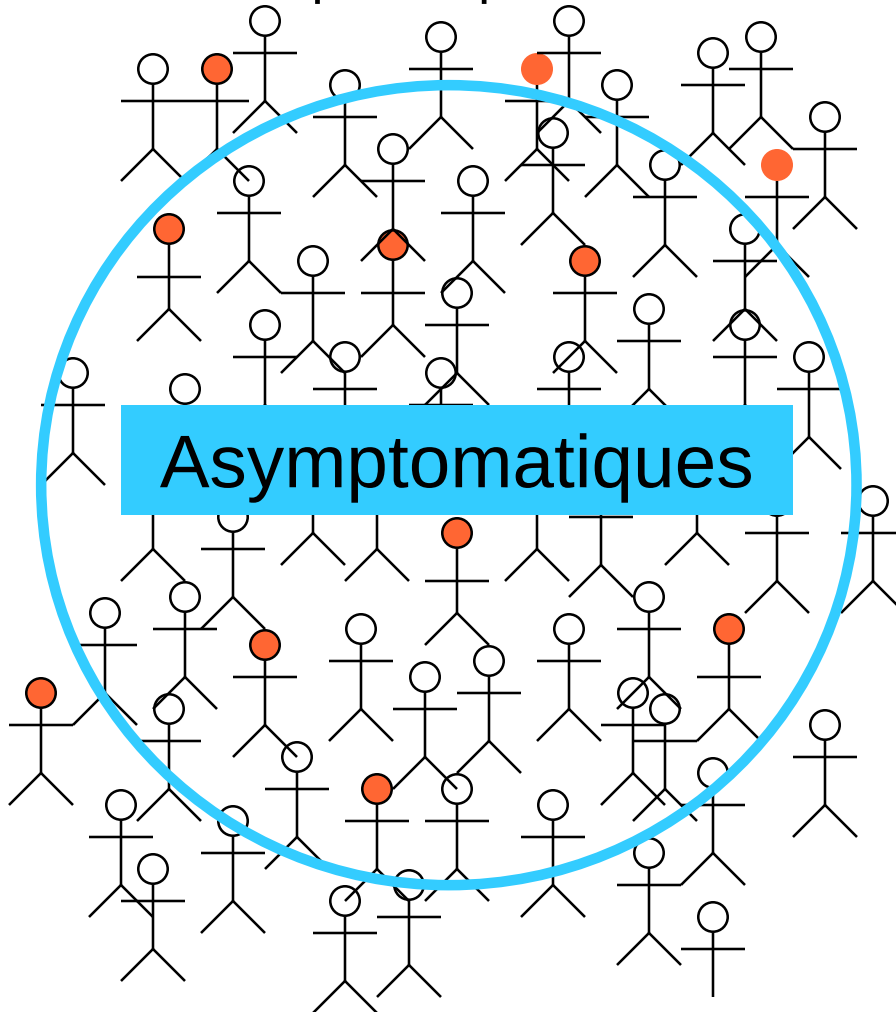


Prévention

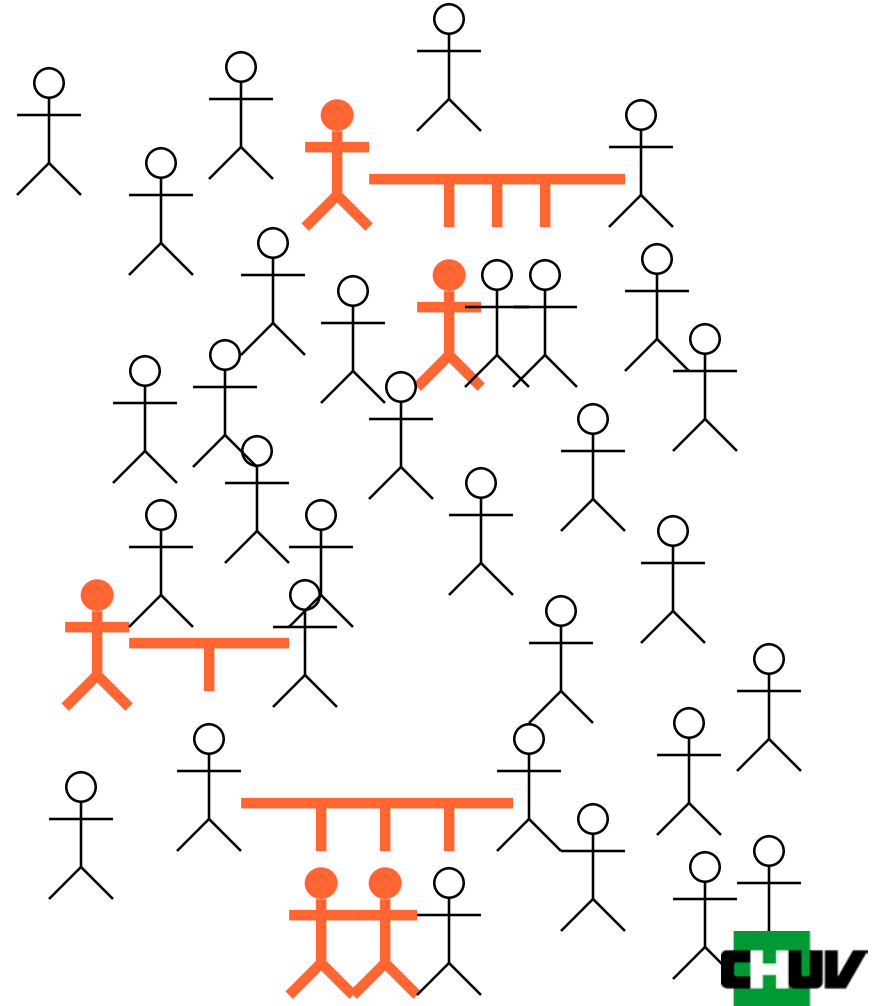


Cible du dépistage: population «saine»

sporadique 80%



familial/héréditaire etc 20%



- **Quel type de médicament provoque spécifiquement des ulcères gastro-duodénaux?**

- A) tétracycline
- B) prednisone
- C) paracétamol
- D) anti-inflammatoires non-stéroïdiens
- E) antidépresseurs

- **Quel type de médicament provoque spécifiquement des ulcères gastro-duodénaux?**

- A) tétracycline
- B) prednisone
- C) paracétamol
- D) **anti-inflammatoires non-stéroïdiens**
- E) antidépresseurs

D

- **Patient de 36 ans présentant depuis 2 ans une maladie de reflux non compliquée. Les symptômes typiques et fréquents de cette maladie sont:**

- A) brûlures rétrosternales
- B) douleurs thoraciques gauches
- C) régurgitations non-acides
- D) bronchopneumonies récidivantes

- **Patient de 36 ans présentant depuis 2 ans une maladie de reflux non compliquée. Les symptômes typiques et fréquents de cette maladie sont:**

- A) brûlures rétrosternales
- B) douleurs thoraciques gauches
- C) régurgitations non-acides
- D) bronchopneumonies récidivantes

A

Clinique: maladie de reflux

- Symptômes-clés:
 - brûlures rétrosternales
 - renvois acides
 - épigastralgies
- Caractéristiques des symptômes:
 - diurnes / nocturnes
 - postprandiaux
 - par période
 - maladie chronique!

Clinique: maladie de reflux

- Symptômes extra-oesophagiens
 - Symptômes respiratoires:
 - Laryngite
 - Toux chronique nocturne
 - Infection des voies respiratoires (broncho-pneumonie)

- **Les symptômes quotidiens du patient sont très pénibles pour lui, l'endoscopie digestive haute a démontré des érosions de petite taille au niveau du bas œsophage (LA A) Comment traitez-vous ce patient?**

- A) mesures générales (régime etc.)
- B) IPP en continu
- C) chirurgie anti-reflux par laparoscopie
- D) chirurgie anti-reflux par laparotomie
- E) IPP à la demande

- **Les symptômes quotidiens du patient sont très pénibles pour lui, l'endoscopie digestive haute a démontré des érosions de petite taille au niveau du bas œsophage (LA A) Comment traitez-vous ce patient?**

- A) mesures générales (régime etc.)
- B) IPP en continu
- C) chirurgie anti-reflux par laparoscopie
- D) chirurgie anti-reflux par laparotomie
- E) **IPP à la demande**

E

Thérapie

- **Principe thérapeutique:**
 - diminuer l'acidité
 - renforcer les mécanismes anti-reflux
 - mesures générales

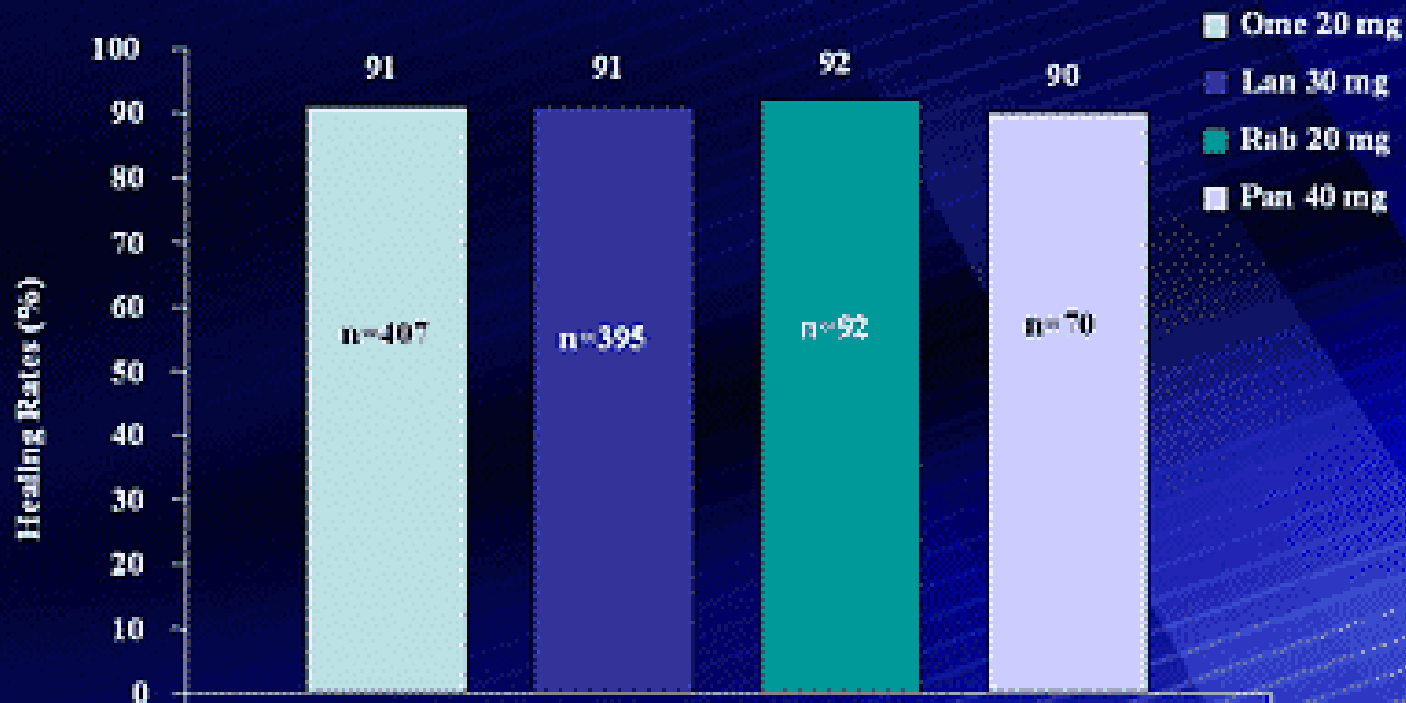
Thérapie

— Diminution de l'acidité

- antacides: pas indiqués
- anti-H₂: (bloqueur des récepteurs d'histamine 2)
peu d'efficacité dans l'œsophagite sévère (40-50% guérison)
- **IPP** (oméprazole, pantoprazole, ésomeprazole etc.)

ttt de choix (taux de guérison 85-95% dans l'œsophagite sévère)

HEALING OF EROSIVE GERD: 8 WEEKS OF TREATMENT WITH PPIs

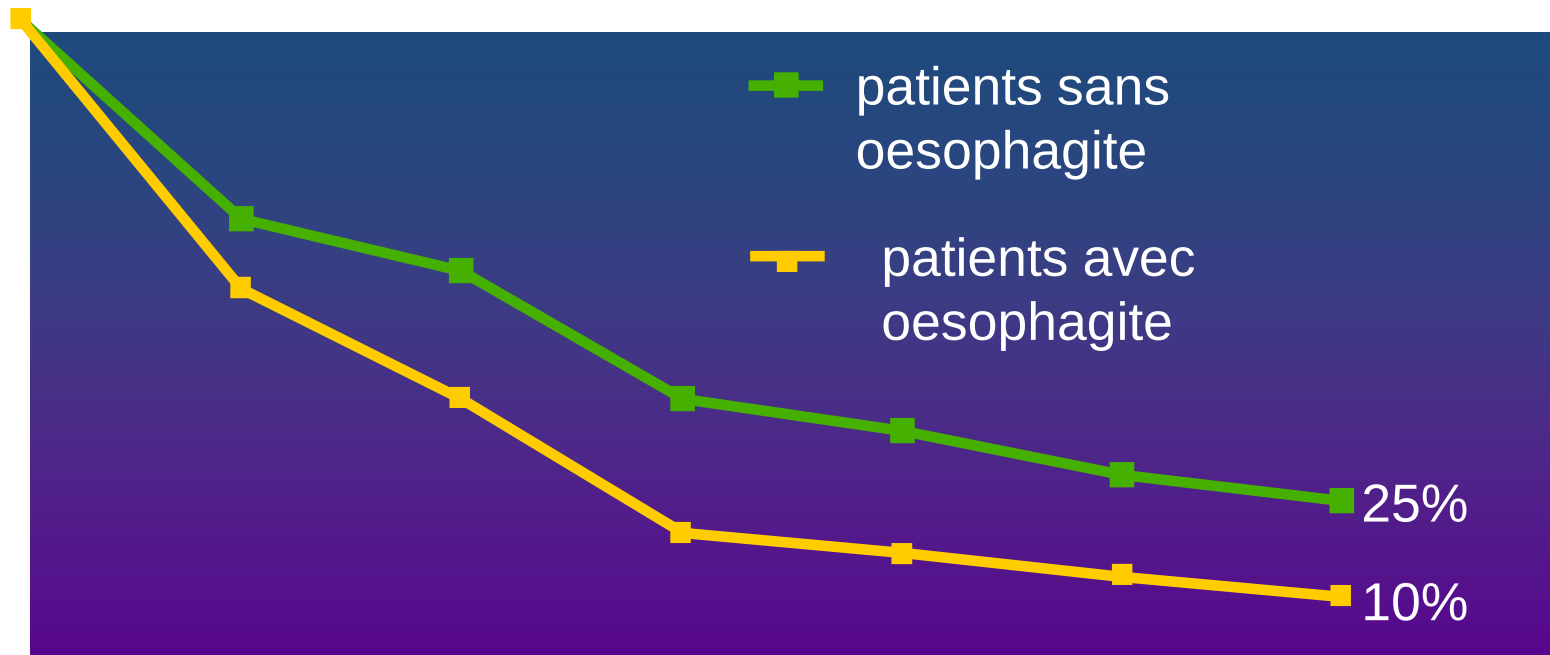


Traitement de la phase aiguë

- **IPP: dose standard pendant 4 semaines**

Récidive: maladie de reflux

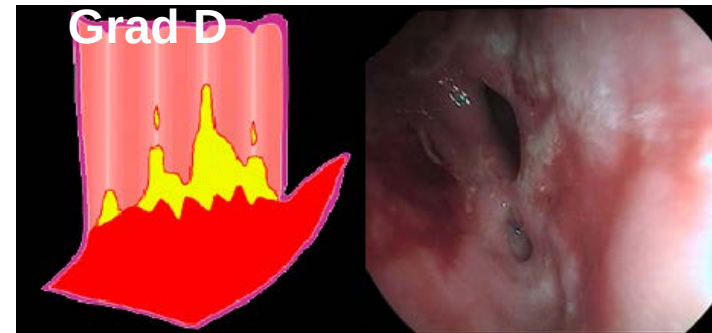
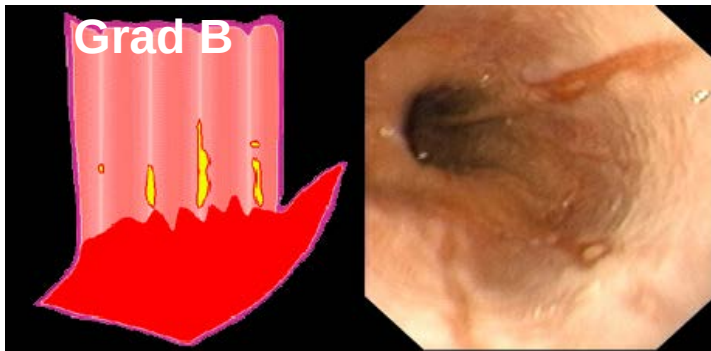
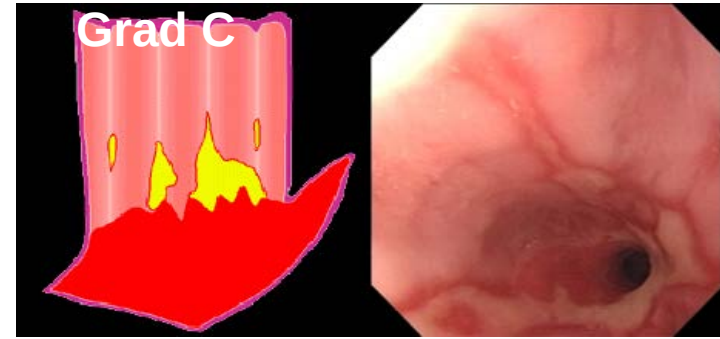
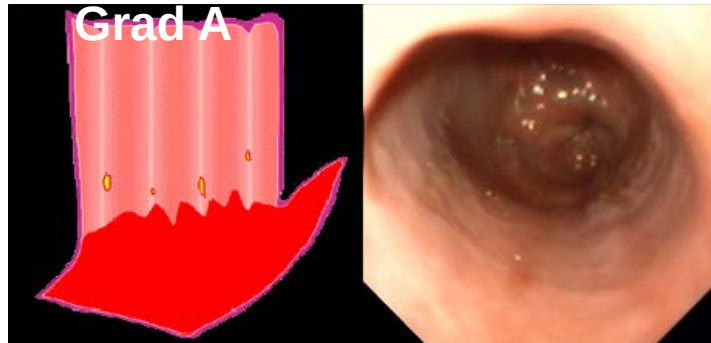
Patients en rémission



Temps depuis l'arrêt du traitement

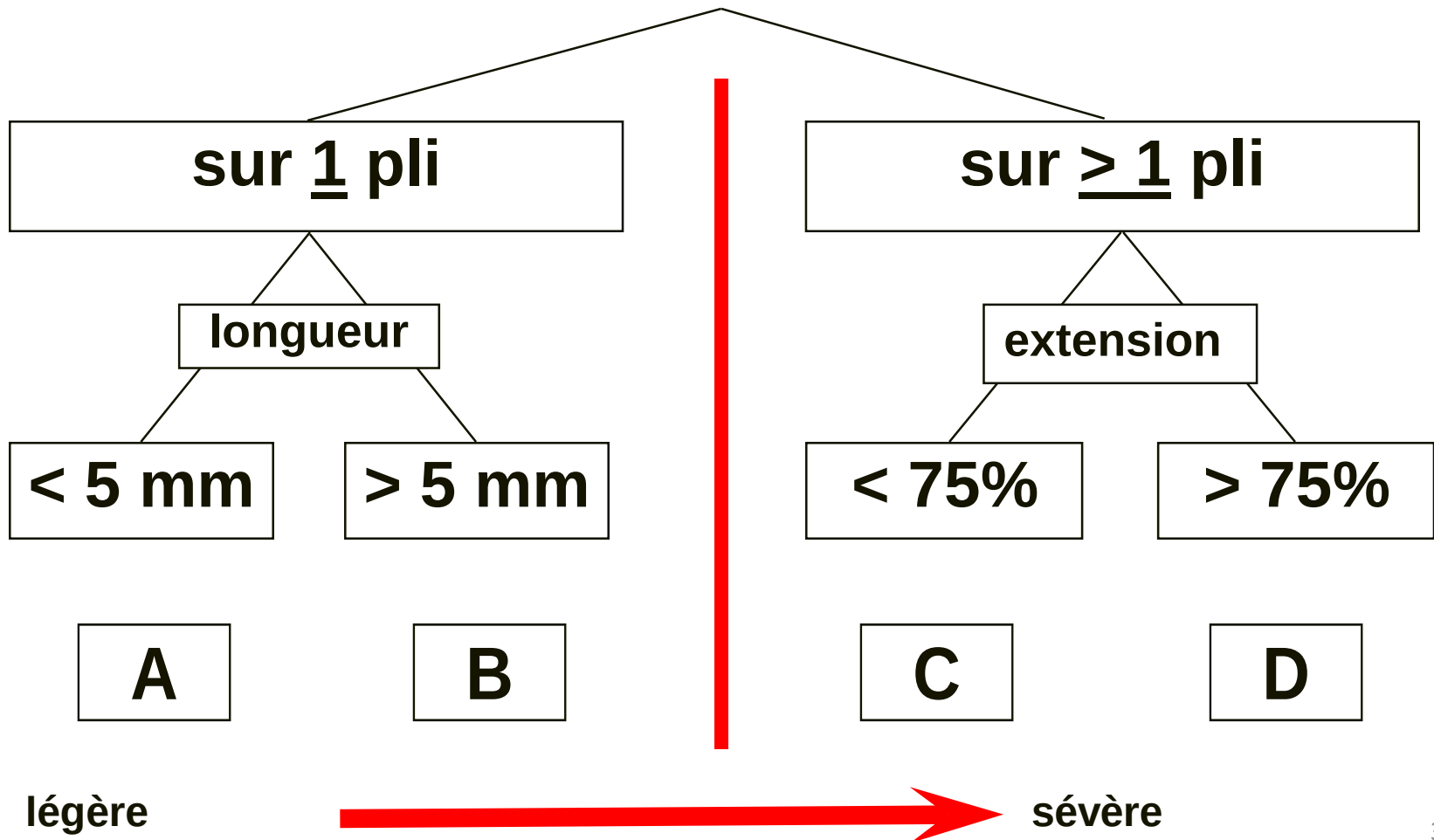
Classification Los Angeles

Longueur et extension circulaire des lésions de la muqueuse



Los Angeles classification

lésion(s) épithéliales(s)



Traitement d'entretien

- **IPP à la demande pour NERD et GERD LA 1 et 2 (dose standard)**
- **IPP en continu pour GERD LA 3 et 4 (demi-dose ou dose standard)**

Conditions pour la chirurgie GERD

- Réponse aux IPP
- pas de perturbation de la motilité œsophagienne
- Pas de risque opératoire élevé

- **Patiente de 26 ans, ayant présenté il y a 4 mois une endométrite en postpartum traitée par antibiotiques, se présente aux urgences pour des diarrhées depuis 3 semaines, actuellement jusqu'à 30 fois par jour, y compris la nuit, parfois accompagnées d'un peu de sang et de douleurs abdominales diffuses modérément intenses. Pas de fièvre, pas de douleurs articulaires, pas d'aphte, pas de voyage récent. Laboratoire : leucocytose modérée à 13.2 G/l, CRP élevée à 32 mg/l. Quelle investigation proposeriez-vous ?**

- A Colonoscopie
- B CT- abdominal
- C Cultures standard et recherche de toxine *Clostridium difficile* dans les selles
- D Calprotectine fécale
- E Dosage de la TSH

- **Patiente de 26 ans, ayant présenté il y a 4 mois une endométrite en postpartum traitée par antibiotiques, se présente aux urgences pour des diarrhées depuis 3 semaines, actuellement jusqu'à 30 fois par jour, y compris la nuit, parfois accompagnées d'un peu de sang et de douleurs abdominales diffuses modérément intenses. Pas de fièvre, pas de douleurs articulaires, pas d'aphte, pas de voyage récent. Laboratoire : leucocytose modérée à 13.2 G/l, CRP élevée à 32 mg/l. Quelle investigation proposeriez-vous ?**

- A Colonoscopie
- B CT- abdominal
- C **Cultures standard et recherche de toxine *Clostridium difficile* dans les selles**
- D Calprotectine fécale
- E Dosage de la TSH

C

Diarrhées grêle vs côlon

Diarrhées type grêle

- Grand volume/selles
 - Liquides/défaites
 - 6-10 x/jour
 - Nocturnes
 - «Pas» sang/mucus
-

Diarrhées type colique

- Petit volume/selles
 - Liquides
 - 10-30x/jour
 - Nocturnes
 - Sang/mucus
-

Diarrhées sécrétoires

~~sans lésions~~

- médicaments:
laxatifs/ AINS
- tumeurs
neuroendocrines
- infectieuses

avec lésions

- colite microscopique
- maladies
inflammatoires
- entérocolite
- ischémique/radique
- tumeurs coliques

Antibiotiques et diarrhées

- Les antibiotiques sont impliqués dans 25% des cas de diarrhées d'origine médicamenteuse; déséquilibre de la flore intestinale – « monoculture » de *Clostridium difficile*.
 - amoxicilline-clavulanate 10% à 25%
 - cefixime 15% à 20%
 - clindamycine 5% à 20%
 - ampicilline 5% à 10%
 - autres céphalosporines 2% à 5%
 - érythromycine 2% à 5%
 - azithromycine 3% à 5%
 - clarithromycine 3% à 5%
 - tétracycline 2% à 5%
 - fluoroquinolones 1% à 2%
 - trimethoprim-sulfamethoxazole < 1%

NAME
ID
1

AGE SEX 27/12/2004
11:43:21

COMMENT
Facility

CPM

- **Un patiente de 65 ans consulte pour température à 39.2°, arrêt de transit et douleurs FIG (très violentes). Les symptômes ont commencé il y a 24 heures. Péritonisme local dans la FIG. Le diagnostique le plus probable est:**

- A) Maladie de Crohn
- B) Colite infectieuse (*Campylobacter jejuni*)
- C) Diverticulite
- D) Appendicite
- E) Peforation de l'intestin grêle

- Une patiente de 65 ans consulte pour température à 39.2°, arrêt de transit colique et douleurs très violentes dans FIG. Les symptômes ont commencé il y a 24 heures. Péritonisme local dans la FIG. Le diagnostique le plus probable est:
- A) Maladie de Crohn
 - B) Colite infectieuse (*Campylobacter jejuni*)
 - C) Diverticulite
 - D) Appendicite
 - E) Peforation de l'intestin grêle

C

- **Un patient de 34 ans consulte pour des diarrhées apparues depuis 2 mois, avec du sang frais, 20 selles liquides diurnes et nocturnes et des douleurs abdominales chroniques depuis 5 mois (crampes). Légère perte pondérale de 3 kg dans le mois passé. Il n'y a pas de fièvre. Quel diagnostic est le *plus* probable?**

- A) Maladie de Crohn
- B) Colite infectieuse (*Campylobacter jejuni*)
- C) Colite microscopique
- D) Colopathie fonctionnelle
- E) Maladie inflammatoire de l'intestin (RCUH/ M.Crohn)

- **Un patient de 34 ans consulte pour des diarrhées apparues depuis 2 mois, avec du sang frais, 20 selles liquides diurnes et nocturnes et des douleurs abdominales chroniques depuis 5 mois (crampes). Légère perte pondérale de 3 kg dans le mois passé. Il n'y a pas de fièvre. Quel diagnostic est le *plus* probable?**

- A) Maladie de Crohn
- B) Colite infectieuse (*Campylobacter jejuni*)
- C) Colite microscopique
- D) Colopathie fonctionnelle
- E) **Maladie inflammatoire de l'intestin (RCUH/ M.Crohn)**

E

Maladies inflammatoires de l'intestin

- CROHN
- RCUH

Epidémiologie Fréquence des pathologies

Incidence de colite ulcéreuse

- 5 à 15 nouveaux cas / 100.000 hab. / an

Prévalence pour la colite ulcéreuse

- 28 à 117 nouveaux cas pour 100.000 habitants

Incidence de maladie de Crohn

- Important gradient Nord-Sud
- 6 à 10 / 100.000 hab. / an, au Nord
- 9 à 3,4 / 100.000 hab. / an, au Sud (IT / ESP)

Prévalence pour la maladie de Crohn

- 34 à 146 pour 100.000 habitants

Manifestation

% premiers diagnostics

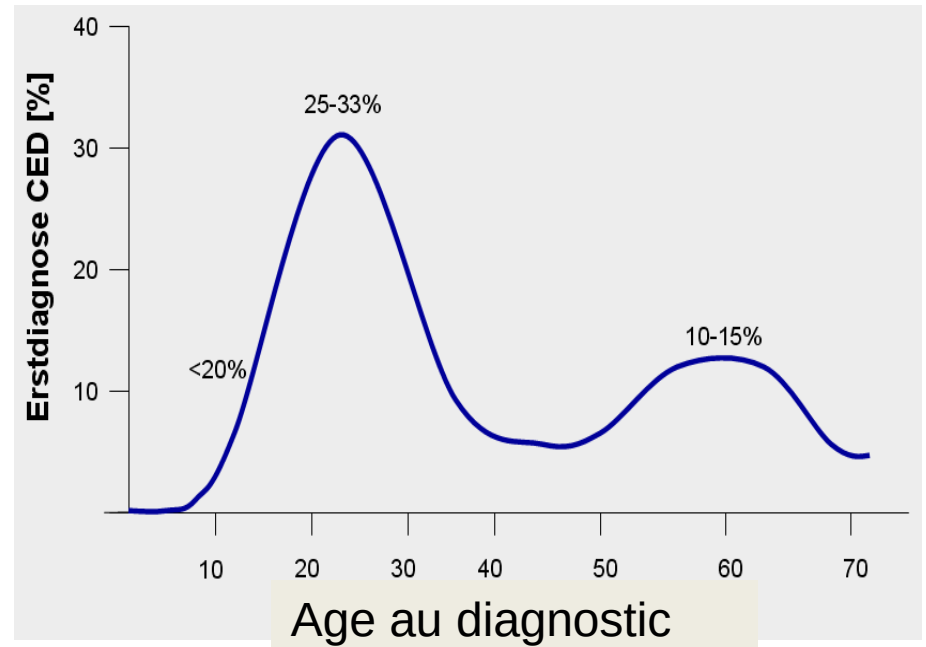
Premier pic de fréquence

entre 20 et 40 ans

Deuxième pic de fréquence

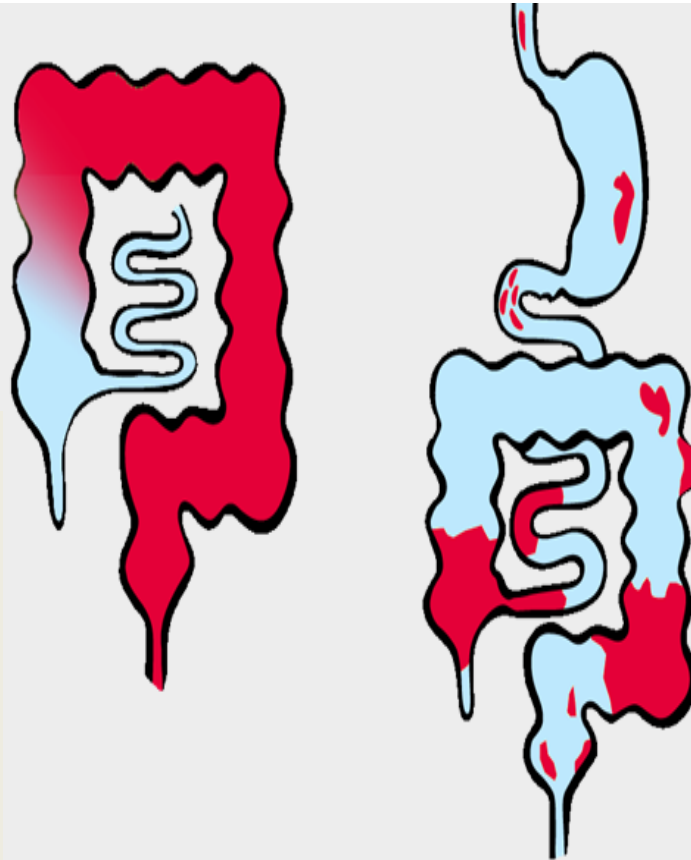
autour de 60-70 ans

20 – 30% des patients ont < 20 ans



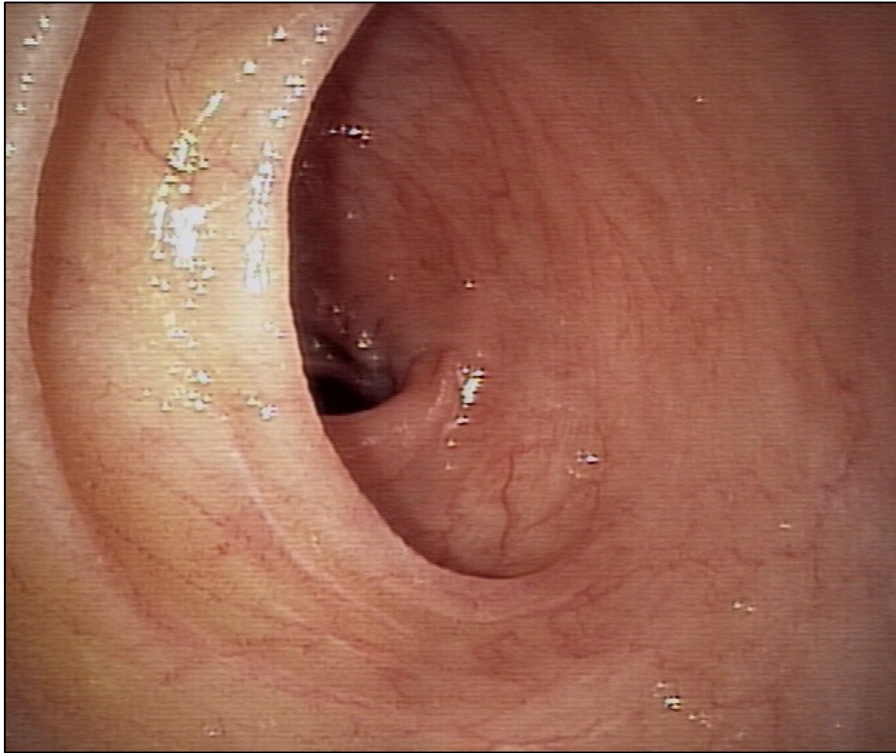
Manifestation intestinale de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse

La colite ulcéreuse touche exclusivement le gros intestin (côlon)
Exception: (rare) « back-wash-ileitis » lors de sévères pancolites l'iléon terminal peut également être touché



La maladie de Crohn peut toucher la totalité du tractus digestif (muqueuse buccale jusqu'à l'anus)

Endoscopie: maladie de Crohn iléon terminal



Normal



Ulcération aphtoïde

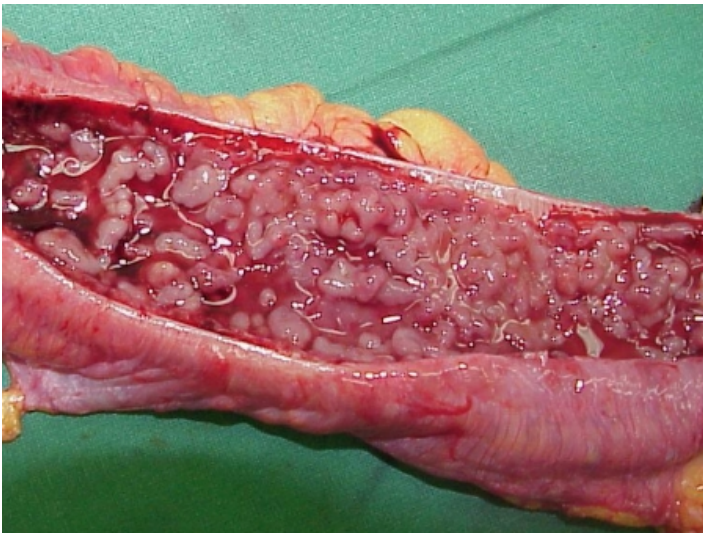
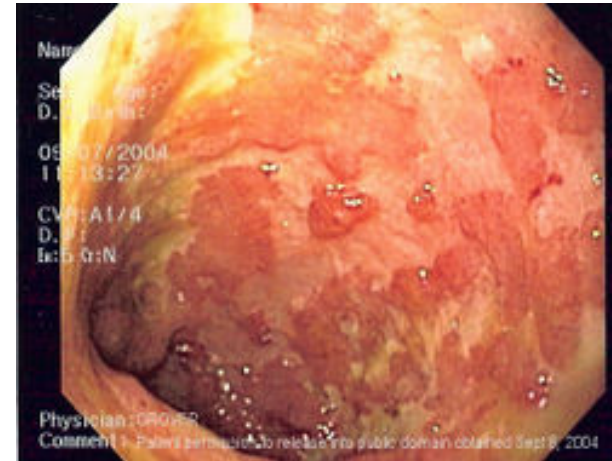
Maladie de Crohn: Complications

- Fistule
- Abscess
- Obstruction intestinale
- Manifestation péri-anale
- Manifestation extra-intestinale (yeux, peau, articulation)
- Malnutrition
- Trouble de la croissance chez l'enfant

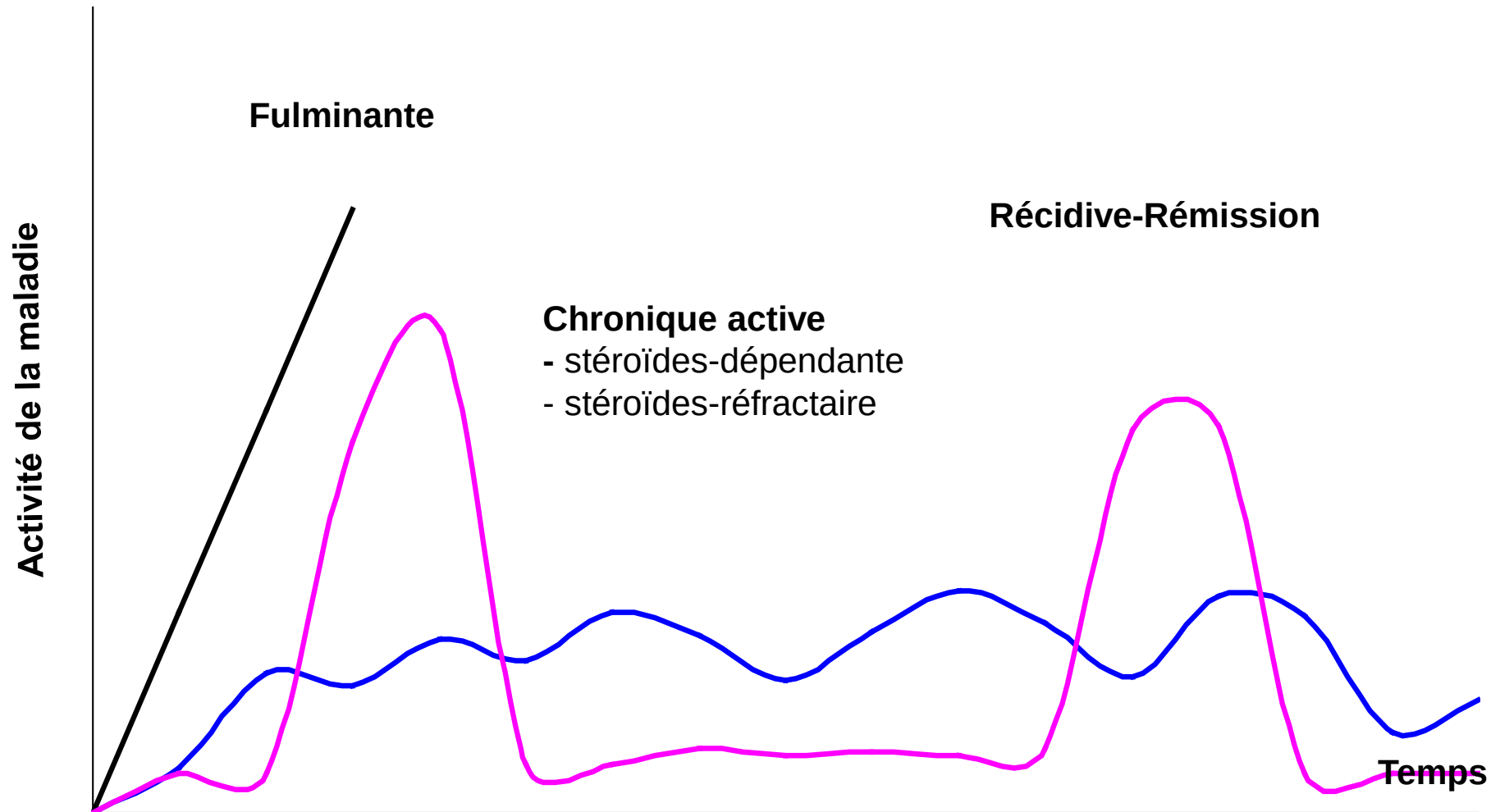


Hanauer SB, et al. Am J Gastro. 2001;96:635-643.

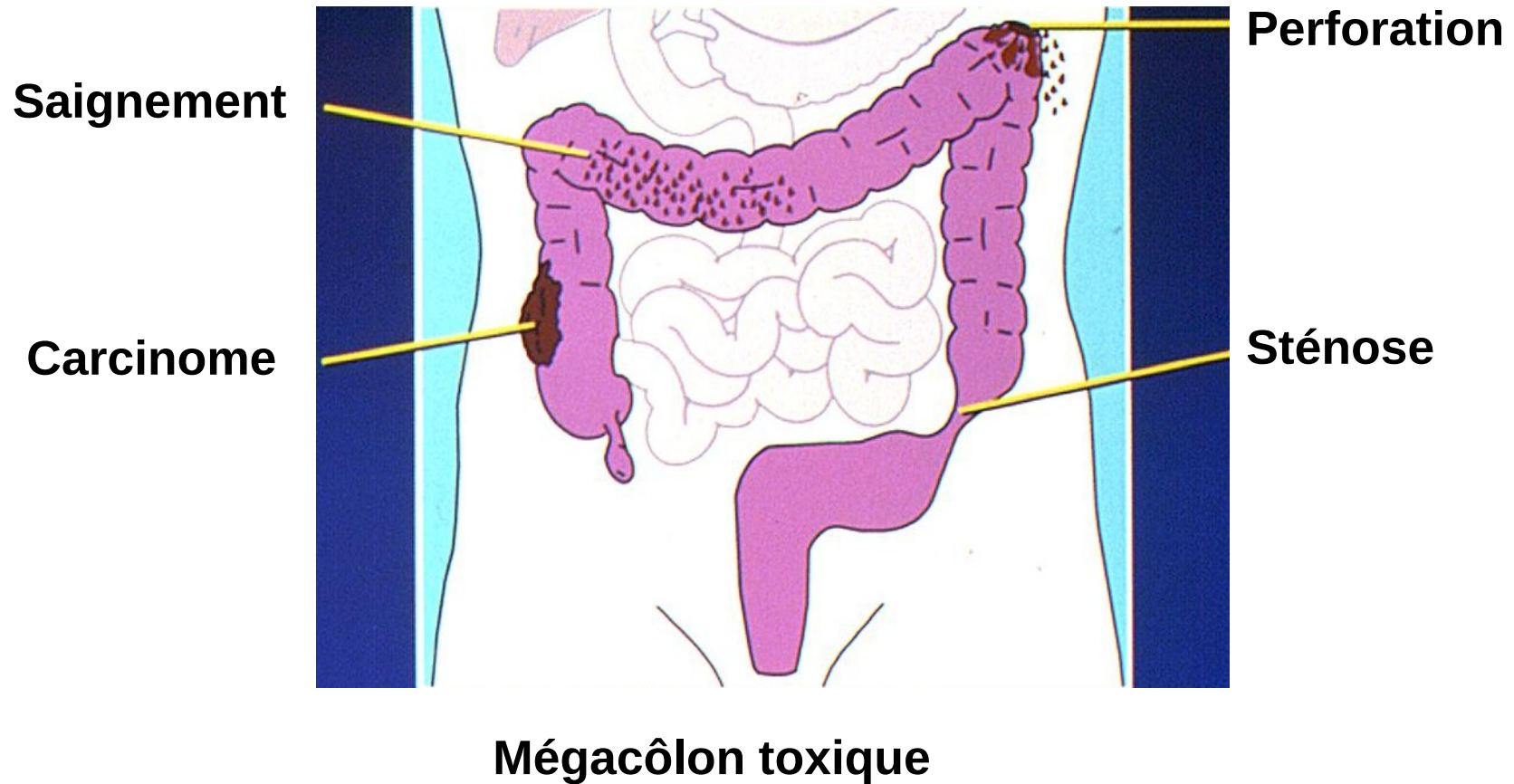
RCUH: Endoscopie



Colite ulcéreuse: Evolution de la maladie



Colite ulcéreuse: Complications



Maladie de Crohn et colite ulcéreuse: Symptômes extra-intestinaux

Peau

- Aphtes, érythème noueux, *pyoderma gangrenosum*

Yeux (7%)

- Episclérite, uvéite, iritis

Articulations (20%)

- Arthrite, Sacro-illite,
- Spondylarthrite ankylosante

Foie

- Cholangite sclérosante primaire (surtout avec la colite ulcéreuse)

Yeux Iridocyclite, uvéite

Bouche

Stomatite,

Peau érythème noueux, *pyoderma gangrenosum*
Hyperkératose

Foie

Cholangite sclérosante primaire

Vésicule biliaire

Lithiase

Pancréas

Pancréatite récidivantes (svt légère) inexpliquée.

Reins

Calculs d'oxalate.

Articulations

Monoarthrite, oligoarthrite, Spondylarthrite ankylosante



Pyoderma gangrenosum



Erythème noueux



Nodules rouges, très douloureux à la palpation, souvent à proximité de la cheville.



- Un patient de 45 ans consulte pour une dysphagie intermittente depuis plus que 10 ans. Il y a 3 ans et 6 ans, il a eu des gastroscopie pour des impactions alimentaires en urgence (faites en Amérique du Sud). De temps en temps des douleurs retrosternales. Pas de brûlures retrosternales. Pas de renvois acides. Pas de perte de poids. Allergies au pollens connue depuis l'enfance. Quel diagnostic est le *plus* probable?

- A) Maladie de reflux peu symptomatique
- B) Oesophagite à éosinophiles
- C) Sténose benigne de l'oesophage
- D) Cancer de l'œsophage
- E) Achalasie

- **Un patient de 45 ans consulte pour une dysphagie intermittente depuis plus que 10 ans. Il y a 3 ans et 6 ans, il a eu des gastroscopie pour des impactions alimentaires en urgence (faites en Amérique du Sud). De temps en temps des douleurs retrosternales. Pas de brûlures retrosternales. Pas de renvois acides. Pas de perte de poids. Allergies au pollens connue depuis l'enfance. Quel diagnostic est le *plus* probable?**

- A) Maladie de reflux peu symptomatique
- B) **Œsophagite à éosinophiles**
- C) Sténose benigne de l'oesophage
- D) Cancer de l'œsophage
- E) Achalasie

B

Definition

Eosinophilic esophagitis: Updated consensus recommendations for children and adults

JACI 2011;128:3-20

Chris A. Liacouras, MD, Glenn T. Furuta, MD, Ikuo Hirano, MD, Dan Atkins, MD, Stephen E. Attwood, MD, FRCS, FRCSI, MCh, Peter A. Bonis, MD, A. Wesley Burks, MD, Mirna Chehade, MD, Margaret H. Collins, MD, Evan S. Dellon, MD, MPH, Ranjan Dohil, MD, Gary W. Falk, MD, MS, Nirmala Gonsalves, MD, Sandeep K. Gupta, MD, David A. Katzka, MD, Alfredo J. Lucendo, MD, PhD, Jonathan E. Markowitz, MD, MSCE, Richard J. Noel, MD, Robert D. Odze, MD, FRCP, Philip E. Putnam, MD, FAAP, Joel E. Richter, MD, FACP, MACG, Yvonne Romero, MD, Eduardo Ruchelli, MD, Hugh A. Sampson, MD, Alain Schoepfer, MD, Nicholas J. Shaheen, MD, MPH, Scott H. Sicherer, MD, Stuart Spechler, MD, Jonathan M. Spergel, MD, PhD, Alex Straumann, MD, Barry K. Wershil, MD, Marc E. Rothenberg, MD, PhD,* and Seema S. Aceves, MD, PhD* *Aurora and Denver, Colo, Milwaukee, Wis, Cincinnati, Ohio, Rochester, Minn, Philadelphia, Pa, Basel and Lausanne, Switzerland, Chapel Hill and Durham, NC, Boston, Mass, Chicago, Ill, San Diego, Calif, New York, NY, Indianapolis, Ind, Tomelloso, Spain, Greenville, SC, and North Shields, United Kingdom*

Eosinophilic esophagitis represents a chronic, immune/antigen-mediated esophageal disease, characterized **clinically** by symptoms related to esophageal dysfunction and **histologically** by eosinophil predominant inflammation

clinically by **symptoms** related to esophageal dysfunction

Adults and Adolescents

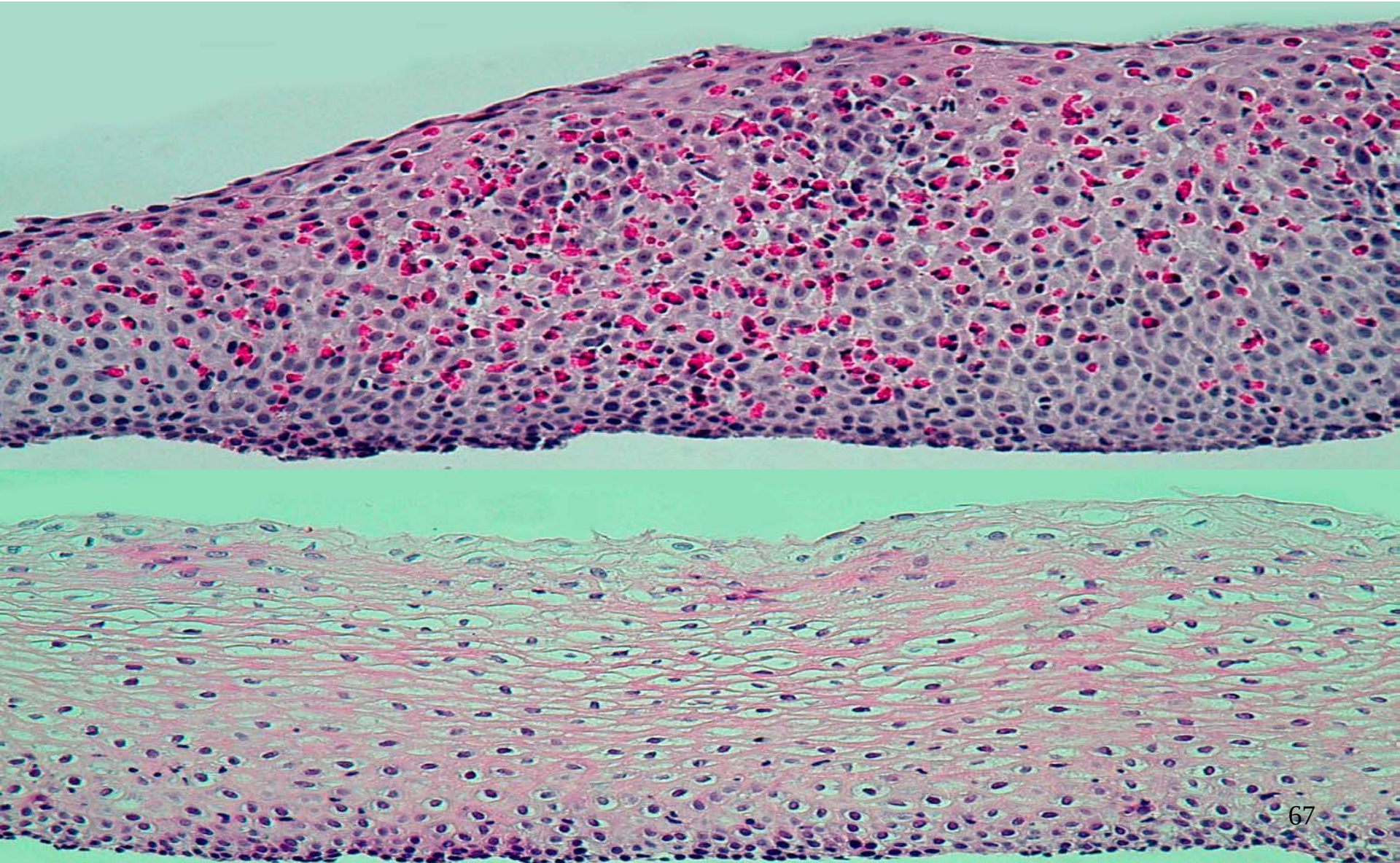
- Dysphagia for solids $\cong 100\%$ (“slow-eaters” and “drinkers”)
- Long lasting food impaction ($>35\%$; 148/414)
- Non-swallowing related retrosternal pain ($>50\%$)



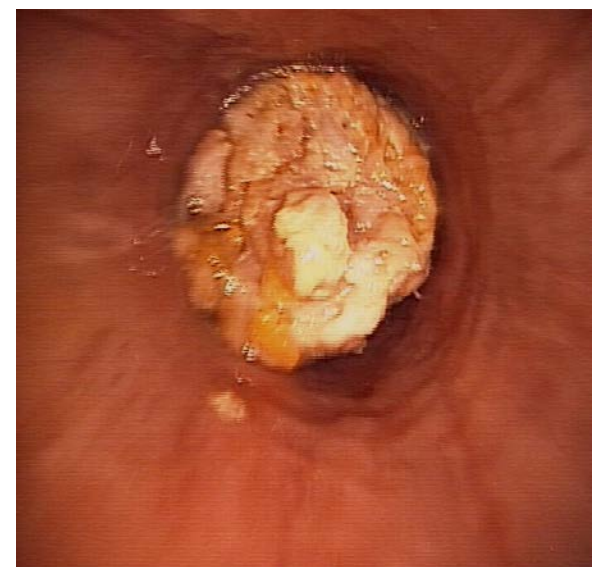
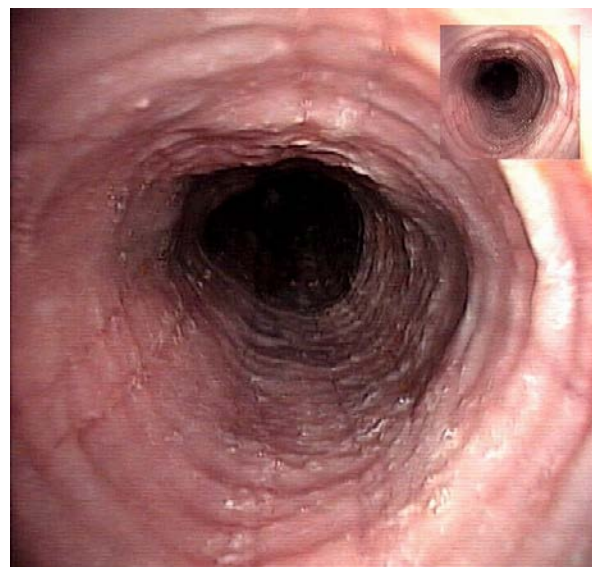
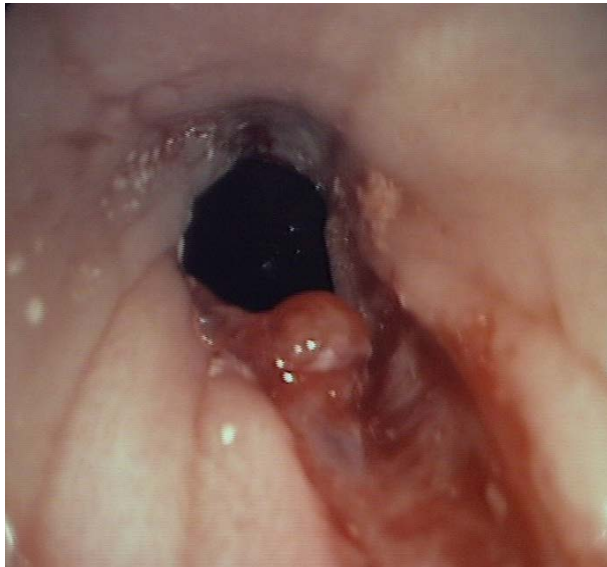
Children

- Food refusal
- Failure to thrive
- Vomiting, Regurgitation
- Chest Pain, abdominal Pain
- Diarrhea

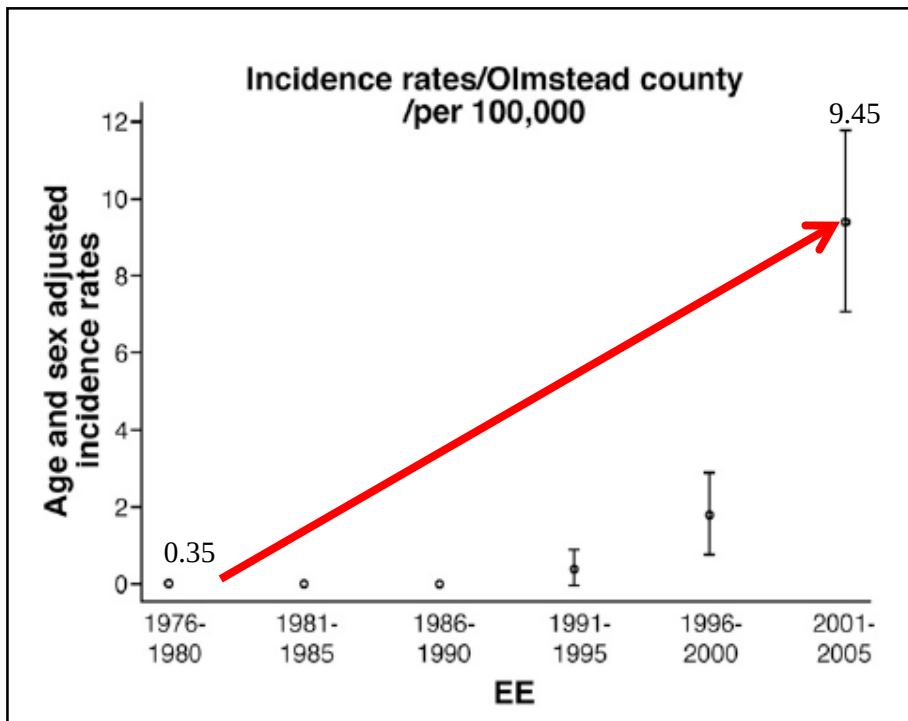
Squamous Epithelium with features of EoE compared with normal findings



Endoscopic manifestation

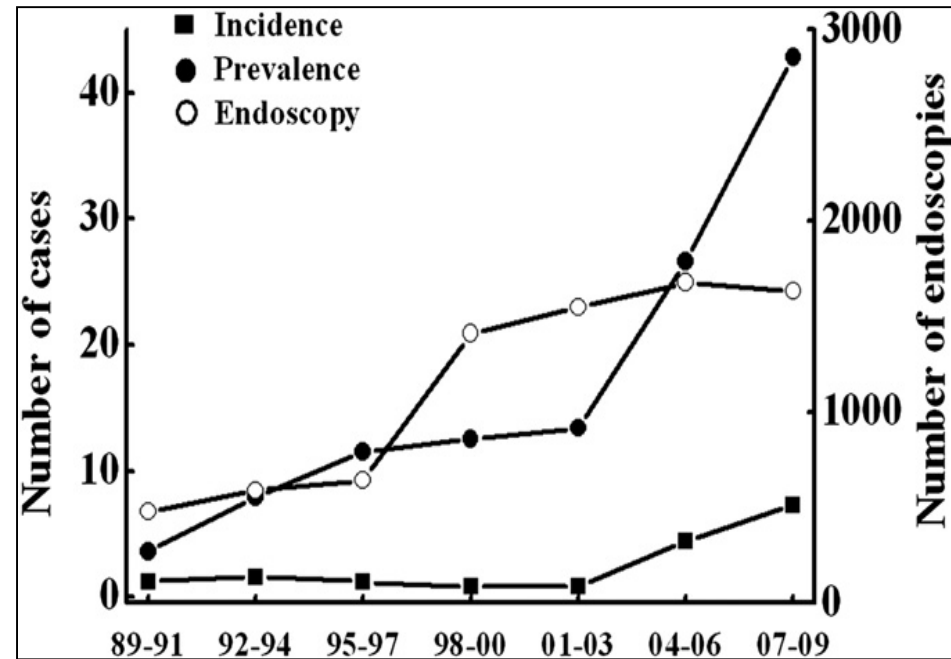


Mayo Clinics, Rochester, USA



Prevalence 55/100,000 => 1/1818

Olten County, Switzerland



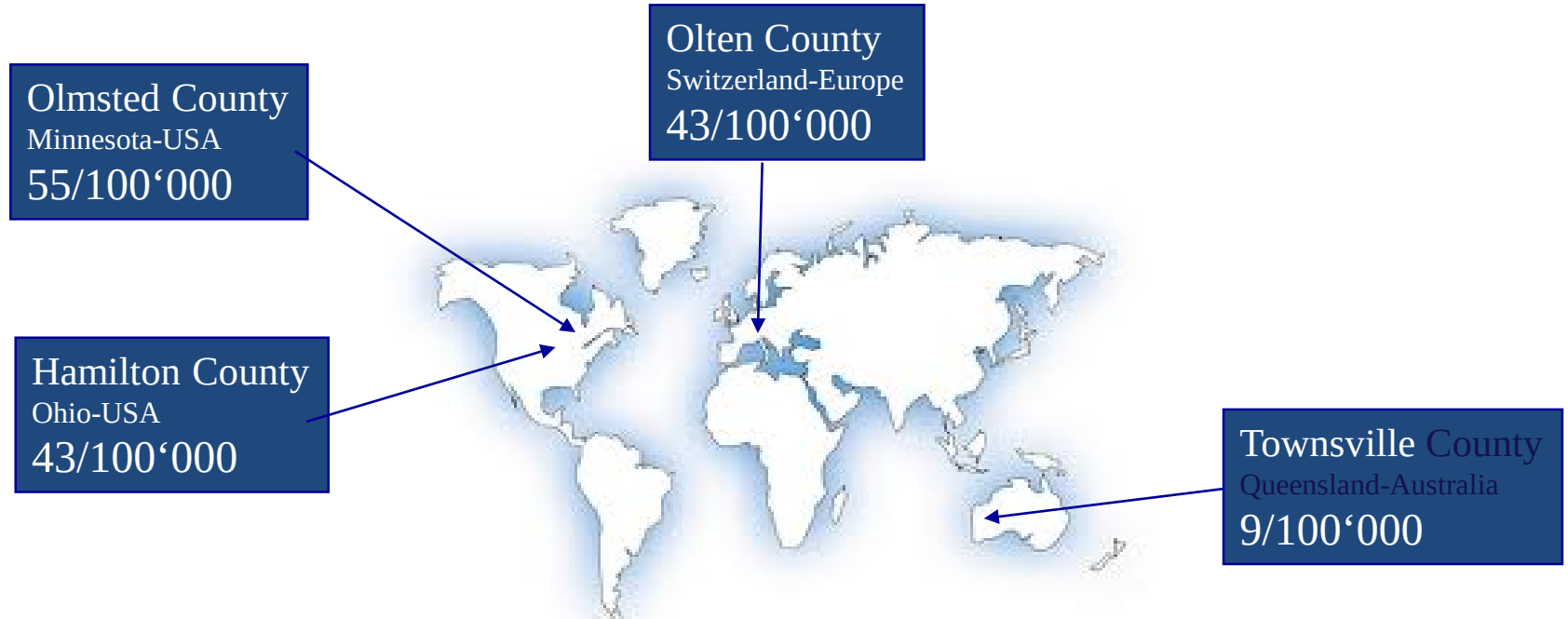
Prevalence 43/100,000 => 1/2325

Prasad G, et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2009



Hruz P, et al. JACI 2011

Eosinophilic Oesophagitis affects individuals in westernized countries with an increasing **prevalence** and **incidence**³

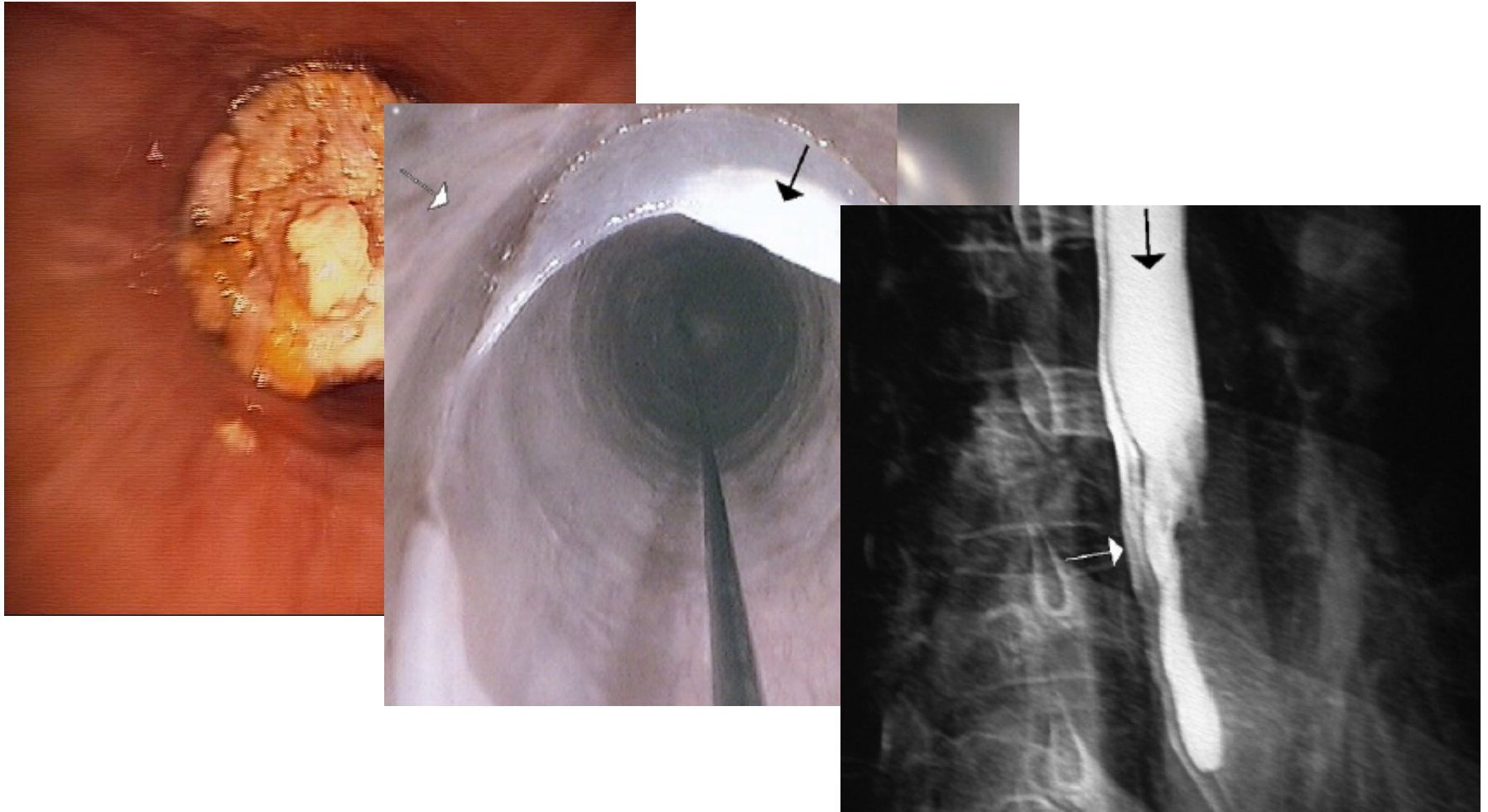


Eosinophilic Oesophagitis affects individuals of all age groups from 1 to 98 years of age⁶

80% of pts = males
80% of pts have allergies

1. Croese et al. Gastro Intest Endos 2003
2. Noel et al NEJM 2004
3. Hruz P. et al. JACI 2011
4. Cherian et al. Arch Dis Child 2006
5. Prasad et al Clin Gastroenterol Hepatol 2009
6. Kapel et al. Gastroenterology 2008

Consequences of remodeling



Therapeutic Options 2014: DDD

Drugs

- Corticosteroids systemically (e.g. prednisone)
- Corticosteroids topically (e.g. budesonide, fluticasone)
- Anti-Allergens (Leukotriene-Antagonists, CRTH2-Blocker)
- Biologicals (e.g. anti-IL5, anti-IL13, anti-IgE)
- Immunosuppressant's (e.g. azathioprine, 6-mercaptopurine)

Diet

- Elemental Diet
- Elimination Diet (individually, allergy-testing based)
- Six-Food Elimination Diet

Dilation

- Un patient de 34 ans consulte pour des diarrhées apparues depuis 2 mois, avec du sang frais, 20 selles liquides diurnes et nocturnes et des douleurs abdominales chroniques depuis 5 mois (crampes). Légère perte pondérale de 3 kg dans le mois passé. Il n'y a pas de fièvre. Quel diagnostic est le *plus* probable?

- A) Maladie de Crohn
- B) Colite infectieuse (*Campylobacter jejuni*)
- C) Colite microscopique
- D) Colopathie fonctionnelle
- E) Colite ulcéreuse (RCUH)

- **Un patient de 34 ans consulte pour des diarrhées apparues depuis 2 mois, avec du sang frais, 20 selles liquides diurnes et nocturnes et des douleurs abdominales chroniques depuis 5 mois (crampes). Légère perte pondérale de 3 kg dans le mois passé. Il n'y a pas de fièvre. Quel diagnostic est le *plus* probable?**

- A) Maladie de Crohn
- B) Colite infectieuse (*Campylobacter jejuni*)
- C) Colite microscopique
- D) Colopathie fonctionnelle
- E) **Colite ulcéreuse (RCUH)**

E

- **Patient (65 ans) immigré de l'Algérie présente un ulcère duodénal *Hp* positif. Il est sous AINS depuis des années pour des douleurs lombaires. Comment traiteriez-vous ce patient:**

- A) un anti-H2
- B) un IPP
- C) un IPP et un antibiotique
- D) un IPP et plusieurs antibiotiques
- E) Seulement par des antibiotiques

- **Patient (65 ans) immigré de l'Algérie présente un ulcère duodénal *Hp* positif. Il est sous AINS depuis des années pour des douleurs lombaires. Comment traiteriez-vous ce patient:**

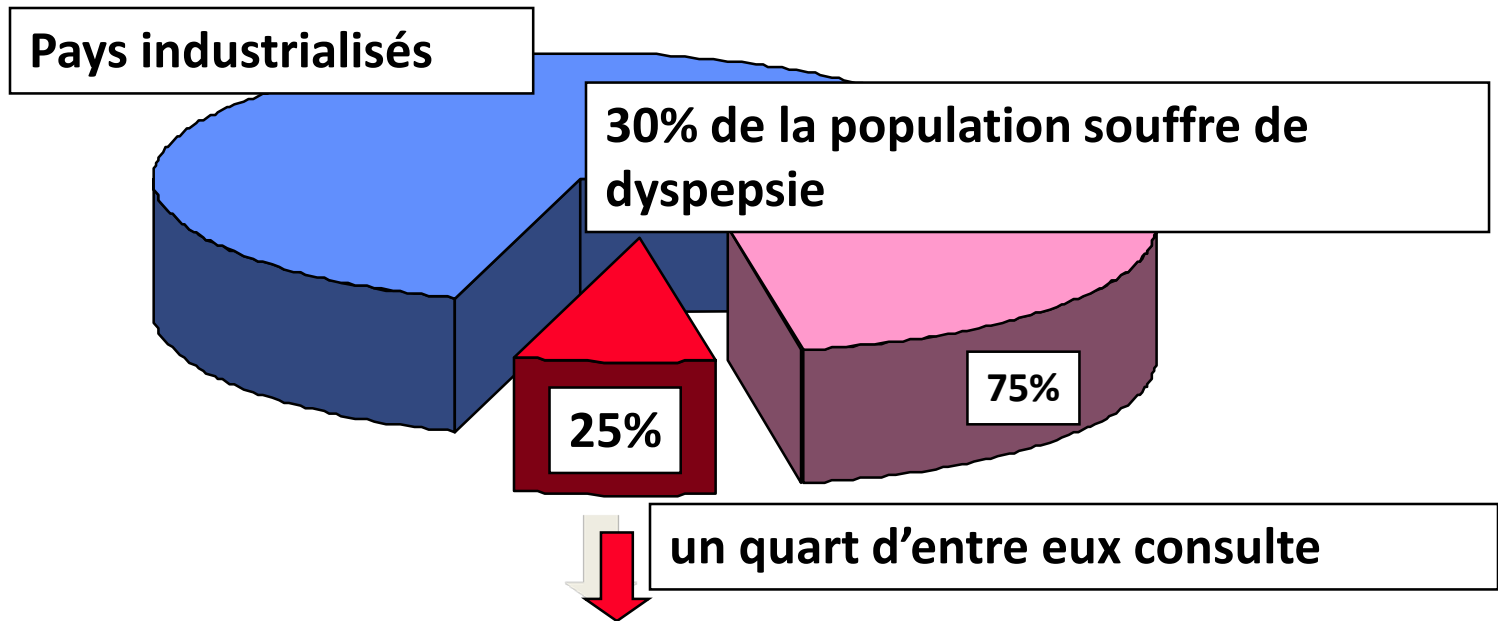
- A) un anti-H2
- B) un IPP
- C) un IPP et un antibiotique
- D) **un IPP et plusieurs antibiotiques**
- E) Seulement par des antibiotiques

D

Dyspepsie

- critères supplémentaires
 - Corrélation avec la prise alimentaire
 - durant ou juste après les repas (œsophage, gastrique)
 - 1-2 heures après les repas (duodénum, vidange gastrique)
 - durée des épisodes douloureux
 - constante (tumeur)
 - intermittente (v. biliaires, gastrite)
 - saisonnière (ulcère peptique)
 - diurne (maladie de reflux)

Epidémiologie de la dyspepsie



2-5% des visites chez le généraliste
40% des patients référés en gastro-entérologie

Etiologie de la dyspepsie

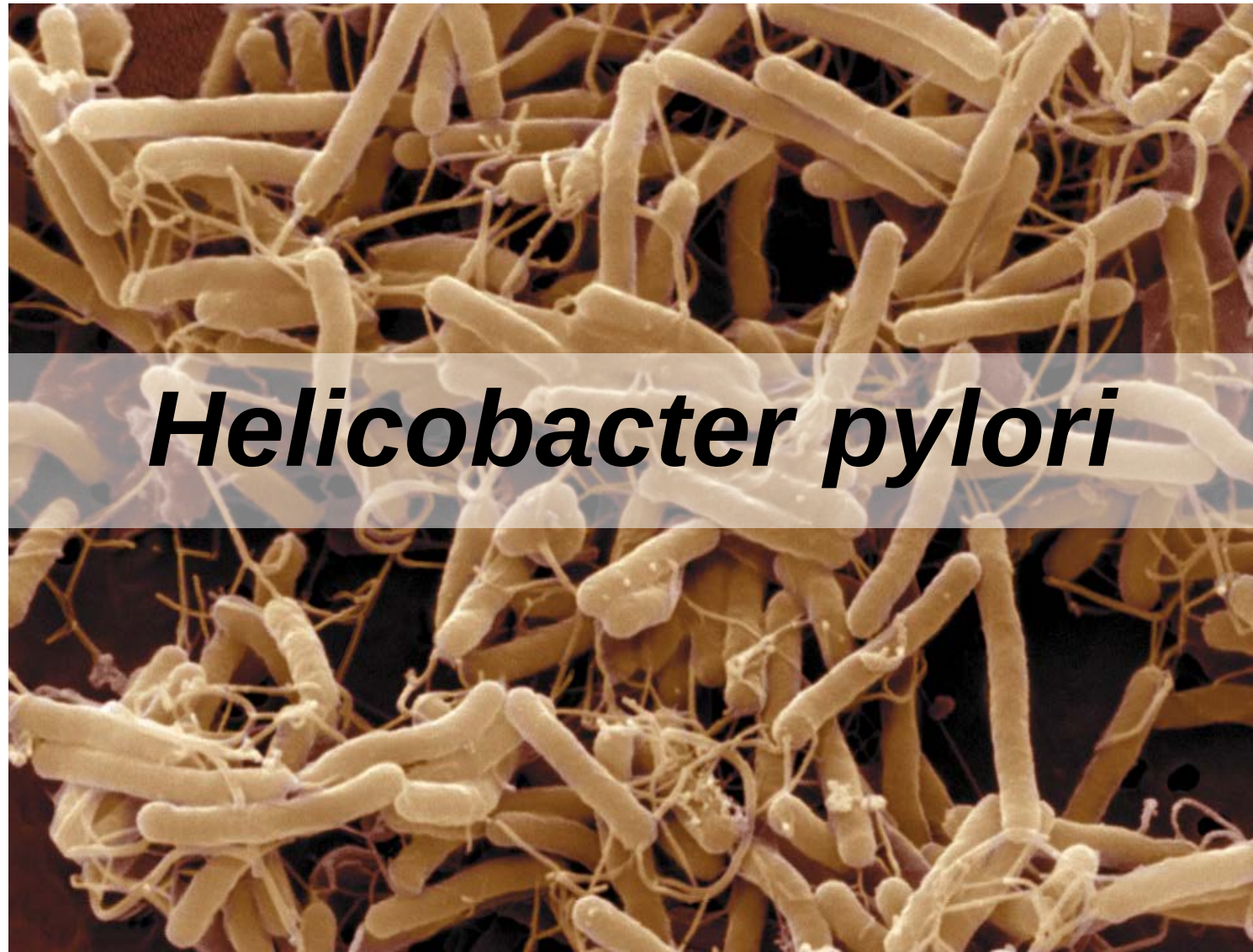
maladie de reflux
gastrites
ulcère peptique
cholécystite
lithiase cholédocienne
intolérance au lactose
cancer gastrique
pancréatite chronique
gastroparésie diabétique
maladie cœliaque
maladie de Crohn
parasites
troubles métaboliques
maladies cardiovasculaires

Causes organiques

40%

**dyspepsie fonctionnelle:
Motilité/sensibilité**

60%



Helicobacter pylori: **Prévalence de l'infection**

Pays industrialisés:

5-15% chez les enfants

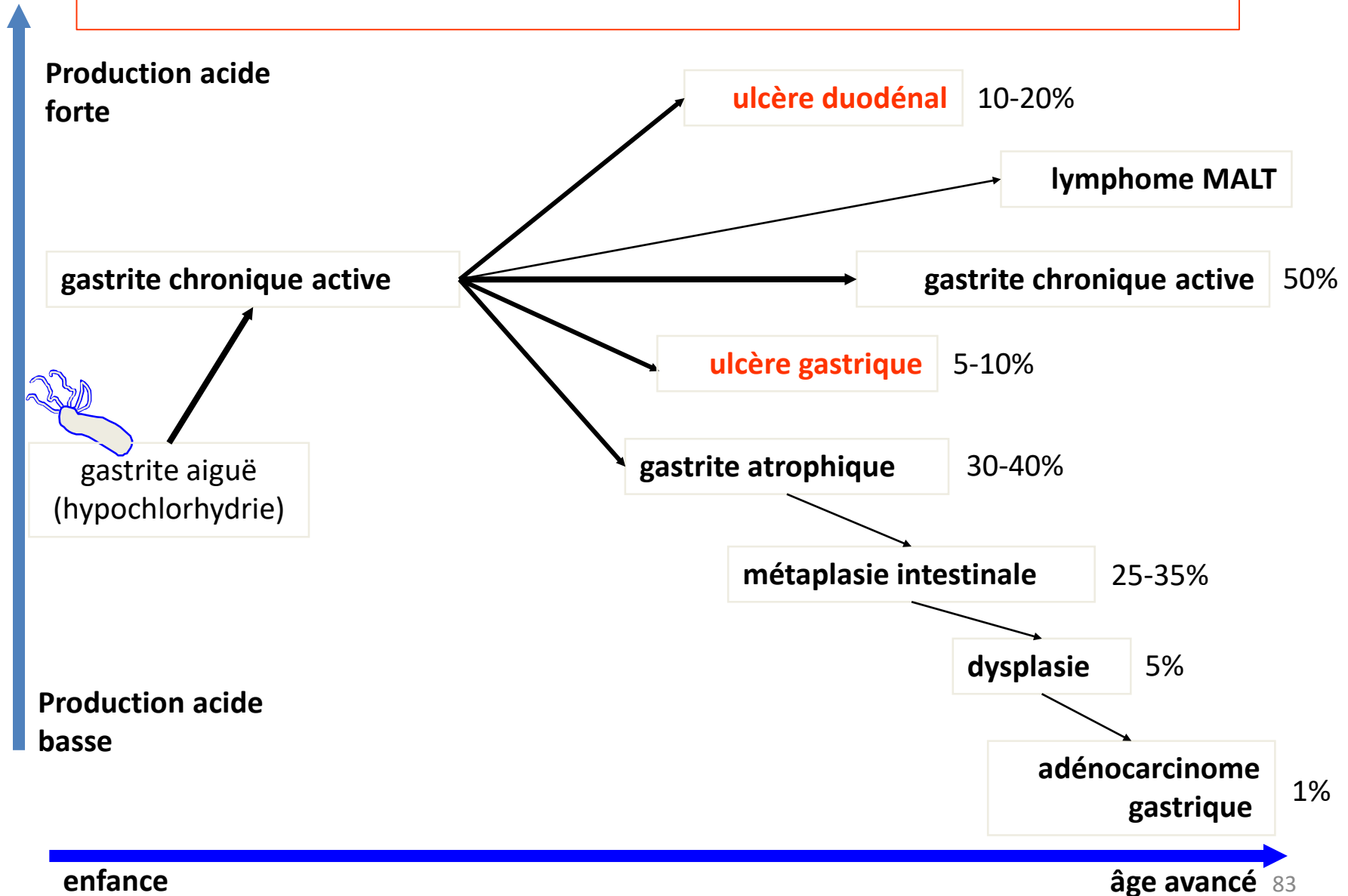
20-65% chez les adultes

Pays en voie de développement

13-70% dans le groupe de 0-20 ans

70-94% dans le groupe de plus de 30 ans

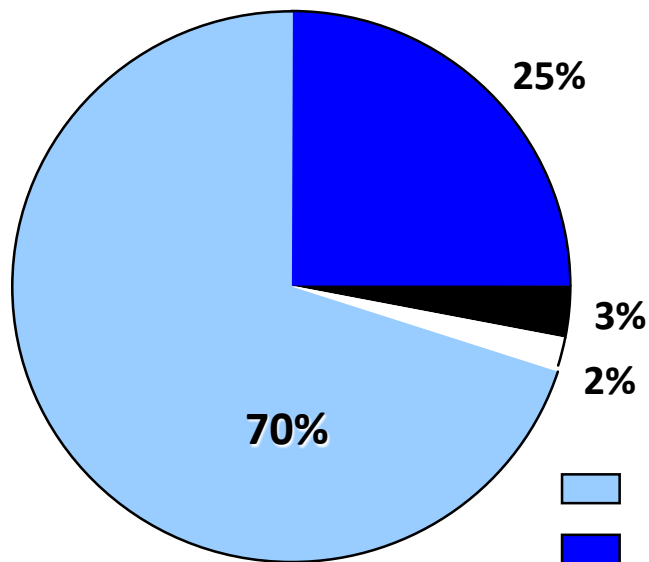
Conséquences de l'infection par *H. pylori*



Étiologies des ulcères peptiques

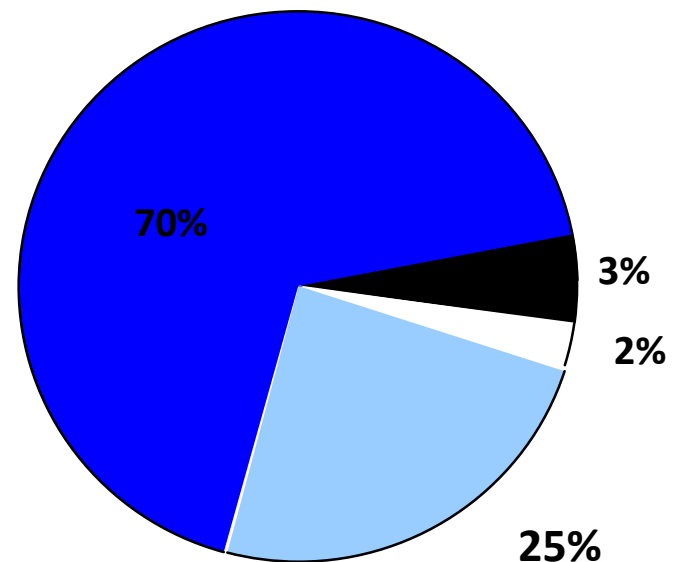
Marshall 1994

Ulcères gastriques



■ *H. pylori*
■ AINS
■ Cancer
■ Autres (Z-E, Crohn, insuf. rénale, cirrhose, hyperparathyr., mastocytose, herpès simplex, BPCO)

2010



Complications des ulcères

- hémorragie digestive haute
 - hématémèse: ulcère gastrique
 - méléna: ulcère duodénal
- Péritonisme
 - perforation
 - pancréatite (pénétration couverte)
- Sténose

- **Un patient de 55 ans se plaint de dysphagie aux solides depuis 2 mois, accompagnée d'une perte pondérale de 4 kg. Il n'y a pas de douleurs, de fièvre ou de comorbidités. Il fume 15 cigarettes/j depuis 30 ans. Depuis 20 ans, il présente un pyrosis traité à la demande par automédication. Vous le voyez en consultation et lui proposez :**
- A) Un traitement par inhibiteurs de la pompe à protons 40 mg/j et une nouvelle consultation dans 4 semaines
- B) Une sérologie *Helicobacter pylori*
- C) Une gastroscopie
- D) Une manométrie œsophagienne
- E) Un transit oesogastro-duodénal

- **Un patient de 55 ans se plaint de dysphagie aux solides depuis 2 mois, accompagnée d'une perte pondérale de 4 kg. Il n'y a pas de douleurs, de fièvre ou de comorbidités. Il fume 15 cigarettes/j depuis 30 ans. Depuis 20 ans, il présente un pyrosis traité à la demande par automédication. Vous le voyez en consultation et lui proposez :**
- A) Un traitement par inhibiteurs de la pompe à protons 40 mg/j et une nouvelle consultation dans 4 semaines
- B) Une sérologie *Helicobacter pylori*
- C) **Une gastroscopie**
- D) Une manométrie œsophagienne
- E) Un transit oesogastro-duodénal

C

Clinique: tumeurs oesophagiennes

- Symptômes-clés:
 - **Dysphagie**
 - **Renvois non-acides/vomissements**
 - **Douleurs rétrosternales**
- Symptômes généraux
 - Perte de poids
 - Asthénie

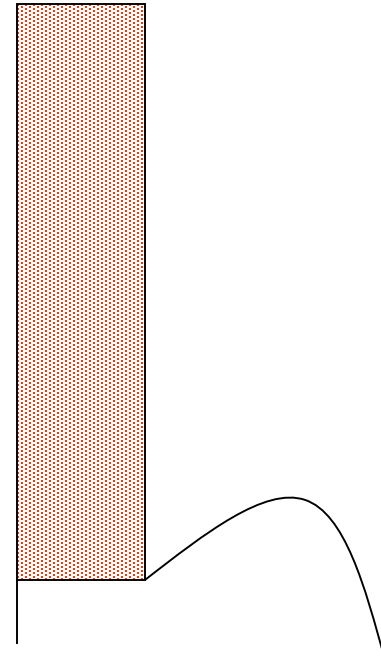
Carcinome de l'oesophage

- Type:
 - Ca épidermoïde
 - Adénocarcinome

Carcinome de l'oesophage

- Localisation
 - Ca épidermoïde

Z-line



Carcinome epidermoïde

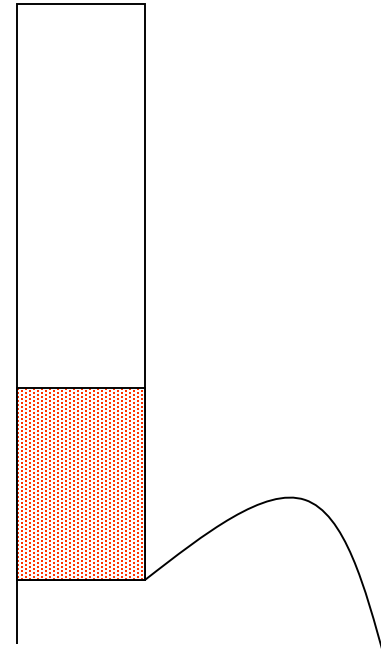
- Incidence 4-5 cas / 100'000
- M/F ratio = 4 / 1.2
- Incidence variable:
 - Iran / Chine 114 /130/100'000

Carcinome de l'oesophage

- Facteur de risque (épidermoïde):
 - Alcool
 - Tabac
 - Lésions caustiques
 - Contacts prolongés: aliments (sténose)
 - Boissons très chaudes

Carcinome de l'oesophage

- Localisation:
 - Adénocarcinome



Développement de l'œsophage de Barrett

Métaplasie-dysplasie-carcinome

épithélium
malpighien
sans lésions

épithélium
malpighien
avec lésions

Métaplasie
oesophagienne

guérison avec
métaplasie

Dysplasie légère

Dysplasie sévère

Adéno-ca



Reflux Symptoms and Esophageal Adenocarcinoma

(Lagergren, NEJM 1999;340:825)

	OR* Squ. Ca Eso (n=167)	OR* Adeno Ca Eso (n=189)	OR* Adeno Ca (n=262)
Cardia Symptoms			
Recurrent reflux symptoms	1.1 (0.7-1.9)	7.7 (5.3-11.4)	2.0 (1.4-2.9)
Long-standing, severe reflux symptoms	-	43.5 (18.3-103.5)	4.4 (1.7-11.0)

***vs. control (n=820)**